جمهورية العراق
وزارة الصحة والبيئة
دائرة الصحة العامة

الارشاد النفسي (المشاورة)

كراس تدريبي مخصص للملاكات الطبية والصحية العاملة في الرعاية الصحية الاولية



اعداد
د. رياض الرديني
رئيس اطباء اختصاص
مدير شعبة الصحة النفسية
دائرة الصحة العامة

٢٠١٩

الفصل الاول

الإرشاد النفسي. (المشاورة): هي عملية علمية, هادفة ومرتبة تتم من خلال **علاقة مهنية** بين مقدم الخدمة (المرشد) والمراجع (المسترشد) لمساعدة المراجع على فهم نفسه والاستفادة مما لديه من قدرات وإمكانات في التغلب على المشكلات التي تواجهه وتحقيق أعلى درجة ممكنة من الاندماج في الحياة بإيجابية, واثبتت التجارب أنّ الإرشاد النفسي. يساعد الأشخاص المضطربين نفسيا وبشكل فعال (عملية علاجية غير دوائية)، غير أنه ليس منافساً للعلاج الدوائي.

ويهدف الارشاد النفسي الى

أولاً: الأهداف الموجهة نحو الفرد:

١) مساعدة الفرد على فهم وتقدير إمكاناته الجسمية والعقلية والاجتماعية والمهنية.
٢) مساعدة الفرد على تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق الشخصي وتقبله لذاته وظروفه وواقعه الجديد.
٣) مساعدة الفرد على تطوير اتجاهات إيجابية نحو الحياة والعمل والمجتمع.
٤) مساعدة الفرد على تكوين علاقات ناجحة مع الآخرين والخروج من العزلة والاندماج في الحياة العامة.
٥) مساعدة الفرد في تنمية قدراته لمواجهة المشكلات والشكاوي التي يعانيها.
٦) مساعدة الفرد في تعلم بعض المهارات والوسائل لضبط عواطفه وانفعالاته وخفض مشاعر التوتر والقلق.
٧) تعزيز الأداء الوظيفي والمجتمعي اليومي لدى المراجع.
٨) العمل على تعديل بعض العادات السلوكية الخاطئة.

ثانيا: الأهداف الموجهة نحو أسرة المريض:

١) مساعدة الأسرة على فهم وتقدير وتقبل حالة المرض وذلك من خلال تزويدها بالمعلومات الضرورية عن الحالة ومتطلباتها وتعديل اتجاهات أفراد الأسرة نحو الفرد المريض.
٢) تقديم المساعدة والدعم النفسي للأسرة في مواجهة الضغوط التي تنشأ عن حالة المرض والتخفيف من آثارها.
٣) العمل على إرشاد الأسرة وتدريب أفرادها على أساليب رعاية المريض وتلبية احتياجاته الخاصة.
٤) مساعدة الأسرة على بناء توقعات إيجابية وموضوعية عن قدرات وإمكانيات المريض.

وان للارشاد النفسي مراحل متسلسله تتضمن الاتي: (لاحظ مخطط الارشاد النفسي في الملحق)

- **المرحلة الاولى : (بناء العلاقة)** هي المرحلة الأساسية في تقديم الإرشاد وتؤثر على التقدم الذي يتم إحرازه في العملية الإرشادية، ويعمل كعامل علاجي في حد ذاته وتتضمن كافة العوامل مثل الاحترام والثقة والشعور بالراحة النفسية.
- **المرحلة الثانية :(التقييم)** يتم تشجيع الأفراد للتحدث عن مشاكلهم :المرشد يسأل أسئلة، يجمع المعلومات عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية واهم المشاكل التي يعانيها الشخص والتعرف على افكاره ومشاعره وسلوكياته.
- **المرحلة الثالثة :(تحديد الأهداف)** بعد تقييم الحالة ومعرفة الشكاوى الرئيسية للمراجع وتحديد افكار ومشاعر وسلوكيات المراجع (التشخيص) فلابد من تحديد التزامات متبادلة بين المرشد والمسترشد، وطريقة العمل، وتحديد الأهداف بشكل واضح لتساعدنا على أن نعرف إذا كان الإرشاد يسير بشكل جيد ومتى ننهي العملية الإرشادية.
- **المرحلة الرابعة :(التدخلات)** "كيف لنا ان نحقق هذه الأهداف"؟ والذي يتوقف على نوع التداخلات المطلوبة والنهج المتبع من قبل المرشد، و على نوع المشكلة وعلى الفرد. وبالتالي فإن اختيار عملية التداخلات تخضع للتكيف ويجب على المرشد تغيير التداخلات عندما يكون التدخل المستخدم لا يعطي النتيجة المرجوة (التقييم المستمرة).
- **المرحلة الخامسة : (الإنهاء)** ان المعيار النهائي لنجاح الإرشاد هو الإنهاء الناجح. يجب القيام به دون الإضرار بالإنجازات التي تم تحقيقها وينبغي أن يتم بحس مرهف، وبقصد وتدريجيا.

المرحلة الاولى (بناء العلاقة) والتي تتطلب الاتي:



١) الالتزام بقواعد العمل لمقدمي خدمات الصحة النفسية في الميدان

على الملاكات الطبية والصحية العاملة في مجال تقديم خدمات الصحة النفسية الالتزام بمجموعة من القواعد والتي هي حق من حقوق المريض النفسي ولايجوز تجاهلها أو اهمها وتشمل:

- **احترام كرامة الأفراد:** وتتمثل في حق الشخص لتلقي معاملة كريمة تليق به كإنسان، وتحفظ كرامته، وتوفير بيئة آمنة له. كما وينبغي على أي عامل في المجال النفسي أن يؤمن بالاتي:
  - قدرات وطاقات الأفراد الذين يحتاجون إلى المساندة والمساعدة.
  - أن يحترم المريض والأفراد الذين يعمل معهم.
  - ينبغي مراعاة الخصوصية المحلية.
  - الإمتناع عن استعمال المصطلحات التي تُلصق بالإنسان وصمةً سلبية أو دونية (مريض, ذهاني, مهووس, مجنون) وعدم استبدال الاسم بالعارض أو المشكلة أو المرض، إذ لا يمكن اختصار الإنسان بمشكلة أو صفة، حيث تشكّل الوصمة الاجتماعية عاملاً سلبياً في طريق تطوير الصحة النفسية.
  - ضمان حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في الصحة والتعبير والحصول على الحماية والرعاية, فللمريض الحق في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، و منها خدمات الصحة النفسية والصحة الاجتماعية. فضلاً عن الحق في عدم التمييز وضمان المساواة بين الجنسين وحصول جميع الفئات على المساعدة الضرورية بغض النظر عن العمر، أو الحالة الاجتماعية و الاقتصادية، أو اللون، أو الدين، أو أية عوامل أخرى.

- **احترام خصوصية الأفراد والحفاظ على السرية:**
  - تشكّل الثقة المتبادلة بين الأفراد، لا سيما في العلاج النفسي والارشاد، عاملاً أساسياً يساعدا في تقدّم العلاج. وينبغي أن تكون مصلحة المريض مراعاة بشكل كامل في كافة مراحل العلاج.
  - **الحق في الخصوصية:** هو العمل على تهيئة الظروف المناسبة لضمان الخصوصية السمعية و البصرية، و عدم السماح بتواجد أي أشخاص ليس من الضروري حضورهم خلال مراحل تقديم الرعاية، أو الإجراءات القانونية.
  - **الحق في السرية:** هي منع البوح بمعلومات حول حالة الفرد إلا في حال كونه يشكل تهديدا لنفسه أو للآخرين (حالة إمكانية الانتحار أو التسبّب بأذية أحد كما في حالات الانتقام) حيث يجب أن تظل المعلومات المتعلقة بالمريض سواءً الجنائية أو الطبية طي الكتمان، ولا يتم البوح بها حتى لأفراد الأسرة إلا بموافقته الصريحة. و يجوز إطلاع أولئك الذين يشتركون في الفحص و العلاج أو التحقيق.

❑ **عدم التسبب بمزيد من ألاذى:**

- ينبغي على أي عامل في مجال الخدمات النفسية والاجتماعية أن يتنبّه لمخاطر التسبّب في أذى. حيث يمكن لأساليب غير ملائمة من وجهة نظر ثقافية أن تسيء إلى الأشخاص بدلاً من أن تساعدهم،
- الحفاظ على مبدء مصلحة المريض اولا وان تكون مصلحة المريض مراعاة بشكل كامل في كافة مراحل العلاج.

امثلة:

- الاستفسار الملحّ وغير المبرّر عن أحداث مأسوية يمكن أن تجعل الأشخاص المعنيين أضعف وأكثر هشاشة وتعرضهم الى مزيد من الأذى.
- في مسائل تتناول ادمان الكحول او سوء استخدام المواد والقضايا العنف الاسري او الجندري وخاصة الجنسية منها هي من المسائل الحساسة في البيئة العربية. لذلك ينبغي الحذر والحفاظ على سرية المعلومات في التعامل مع الناس.

❑ **المشاركة وتوفير المعلومة للمريض:**

- العلاقة بين المريض والمعالج ليست أحادية، بل تُبنى وتتطوّر عن طريق التفاعل والإصغاء النشط. فللمشاركة أهمية خاصة في مسيرة الشفاء لأنّها تعزز شعور الناس بقدراتهم وإدارتهم لحياتهم.
- ينبغي ان يحصل كل مريض على معلومات كاملة و صحيحة عن حالته، و كذلك الخيارات الصحية و القانونية المتاحة له، بلغة مناسبة بغض النظر عن معتقدات مقدمة أو مقدم الخدمة، و ذلك لتمكين المريض من اتخاذ القرار الملائم له.
- إنّ الحرص على إشراك الفرد/ الأفراد التي تحتاج إلى المساعدة في عملية المساندة والعلاج والعمل على تطوير قدراتهم, وهذا يعطيهم شعوراً بالإنجاز وهو في حدّ ذاته عامل من عوامل الشفاء.
- للمريض الحق في تقرير مصيره: و هو حق المريض في اتخاذ قراراته الشخصية بدون ضغط أو إكراه سواءً من الأسرة، أو مقدمي الرعاية، و أمثلة هذه القرارات الخضوع لفحوصات, أو تقديم شكوى أو اختيار الأشخاص المرافقين أثناء تلقي الرعاية.

❑ **تجنّب خلق الإحساس بالاعتماد والاتكالية أو ترسيخه:**

يجب على العاملين في مجال خدمات الصحة النفسية والاجتماعية العمل بكل الوسائل الممكنة على تعزيز ثقة الفرد بنفسه وبقدراته وتجنّب خلق الإحساس بالاعتماد والاتكالية أو ترسيخه.

❑ **احترام المعتقدات الثقافية والدينية والمجتمعية السائدة:**

إن تحدّي المعتقدات السائدة قد يجلب أضراراً كبيرة ويؤثّر على عملية المساعدة وفعاليتها. ففي بعض المجتمعات، قد يكون التعاون مع المعالجين التقليدين وزيادة معرفتهم بمواضيع الصحة النفسية ذا فائدة للأفراد المعنيين بالعلاج.

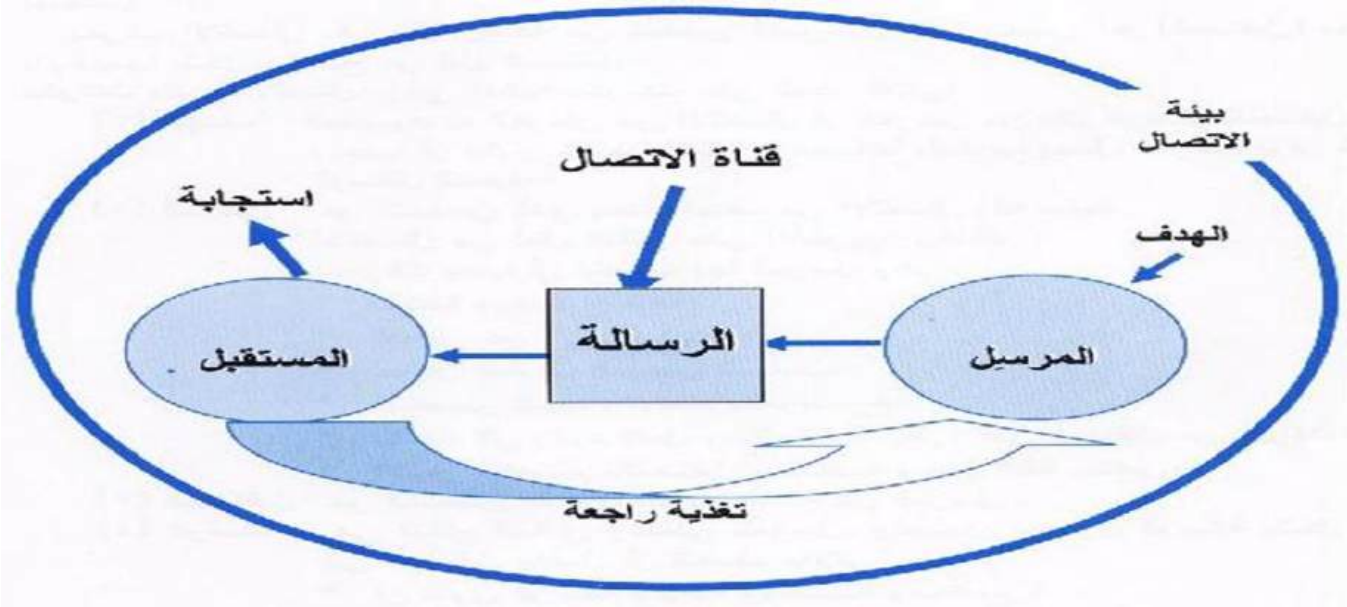
❑ **التعامل بحذر مع الأدوية:**

ضرورة الالتزام بترشيد استخدام الدواء, والحرص على عدم صرف الادوية النفسية الا وفق القائمة المسموح بها ضمن الرعاية الصحية الأولية ومن قبل الملاكات الطبية المتدربة حصرا بعد اجتياز دورة التدريب حول دليل راب الفجوة العلاجية للاضطرابات النفسية فالكثير من الأدوية النفسية تسبب الإدمان فضلاً عن آلاثار الجانبية السلبية للدواء, لذلك ينبغي اللجوء إلى الإرشاد والمساندة وحصر استخدام الأدوية النفسية بالحالات الشديدة التي تتطلّب ذلك, مع تزويد المريض أو مقدمي الرعاية بكافة المعلومات المتعلقة بالدواء.

٢) اتقان المهارات الست للتواصل وتجنب الاخطاء الشائعة له

- إن قدرة الملاكات الطبية والصحية في اقامة علاقة جيدة وثقة متبادلة مع المراجعين هي من العوامل المهمة في نجاح مهمتهم، فمثل هذه العلاقة تساعد في الاتي:
  - الوصول الى التشخيص الصحيح.
  - وضع خطة العلاج المناسبة.
  - تزيد من ثقة المراجع وقناعته بمقدم الخدمة.
  - تزيد من ثقة مقدم الخدمة بنفسه واحترامه لذاته.

- **ماهو التواصل:** بكل بساطة يعني عملية نقل المعلومات او الأفكار (الرسائل) من ذهن الفرد الأول (ويسمى المرسل) الى ذهن الفرد الثاني (يسمى المستقبل) وبالعكس (الرد عليه) لاحداث فهم مشترك لشيء ما بينهما.
- **عناصر التواصل:** هي المرسل, الرسالة, الوسيلة, المستقبل, بيئة الاتصال, التغذية الراجعة, وان هناك هدف للتواصل الا وهو الوصول الى تقارب وتوافق بالافكار والتصورات بين الطرفين (المرسل والمستقبل).



- **انواع التواصل:**
  - **التواصل اللفظي:** أي المعلومات التي يتم تبادلها كلامياً (المنطوقة أو المكتوبة).
  - **التواصل غير اللفظي:** (لغة الجسد) إنه يشمل التأثير الذي تتركه ملامح وإيماءات الوجه، والتحديق، ووضعية الجسد، والتعبيرات التي تظهر شعورك ويعكس الموقف الذي تتخذه. ويشكل ٦٥% او اكثر من مجموع الاتصال.

- **قاعدة عامة: اذا تعارضت الرسالة اللفظية مع لغة الجسد فالعقل يميل الى تصديق لغة الجسد.**
- **لاستخدام التواصل غير اللفظي في المقابلة مع المراجعين اهمية كبرى لكي يشعر المُراجع بأن العامل في المجال الصحي مهتم به، وكثيراً ما يوصل الرسالة بشكل أكثر وضوحاً ومصداقية واستخدامه يساعد في الوصول الى التشخيص والعلاج.**

المهارة الاولى :الاستخدام المفيد للتواصل غير اللفظي

- **اعطي الوقت اللازم للمراجع:** قم بتحية المراجع بحرارة، قدم نفسك وعرف عن مهنتك وبين واجبك واستعدادك لتقديم المشاورة له , اكسر الجليد من خلال البدأ بالحديث في أمور عامة (كالجو اليوم او كيفية الوصول للمركز الصحي) ثم بين له ان كل مايدور من حديث بينكما سيكون سريا ولايمكن ان يطلع عليه أحد, أسال عن اسم المراجع حين يكون يكون مستعداً للحديث, واجعله يشعر أن لديك متسعا من الوقت, ولاتجعله يشعر بانك على عجل, ولا تنظر إلى ساعتك, اكتب ملاحظاتك أثناء تحدثك معه.
- **وضعية الجلوس**: ان خيار الجلوس على الطرف الجانبي للمراجع هو الخيار الامثل للجلوس وان يكون رأسك وعيناك بنفس مستوى رأس وعيني المُراجع. ولا تقف بحيث يكون رأسك وعيناك بمستوى أعلى من رأس وعيني المُراجعة.
- **الوضعية المنفتحة والجلوس بميلان بسيط الى الامام**: ان استخدم وضعية الجلوس المنفتحة هي الطريقة الافضل فإن وضع رجل فوق الأخرى أو وضع يد فوق الأخرى قد تدل على أنك منغلق او تنتقد ما يقوله المراجع أو أنك لا تستمع له. وإن استخدام الوضعية المنفتحة يظهر أنك منفتح وترحب بالمُراجع وبما يقوله. كما وأن الإنحاء البسيط إلى الأمام باتجاه المُراجع من وقت لآخر يعتبر دلالة تلقائية على المشاركة في الموضوع.
- **تجنب العوائق الحسية**: اجلس قريبا بمسافة من المراجع وتجنب كتابة الملاحظات أثناء حديثه وانما أثناء تحدثك معه, ولا تجلس خلف طاولة او وضع اي حاجز بينك وبينه. مع أهمية احترام ابقاء مسافة بينكما (مسافة ذراع تقريبا). ومن المهم ان يكون جزء من باب غرفة المشاورة من الزجاج (كلما كان ذلك ممكنا) او عدم غلق الباب بالمفتاح وان يكون المشاور اقرب الى جهة الباب, ومن المهم أيضا ان تكون مسترخيا اثناء الجلسة فإن اتخاذ موقف مسترخ وطبيعي مع المُراجعين هو أمر هام, وتجنب التحرك بسرعة ولا تكن متوترا او تتحدث بعصبية.

المهارة الثانية :استخدام ألاسئلة ذات النهايات المفتوحة:

- من أجل بدء نقاش أو جلسة إرشادية نفسية مع مُراجع يلزم على المعالج أن يقوم بطرح الأسئلة, إن طرح الأسئلة يساعد في الحصول على معلومات منه وتحديد وتوضيح المشاكل وتجزئتها إلى أجزاء صغيرة ليمكن التعامل معها بشكل أفضل.
- ان الأسئلة ذات النهايات المغلقة عادةً ما تبدأ ب"هل أنت"،" هل قمت ب"،" هل فعلوا كذا"،" هل هم ") وتكون الإجابة عليها ب"نعم "أو" لا ".
- وان استخدام أسئلة ذات نهايات مفتوحة تبدأ ب"كيف"،" ماذا"،" متى"،" أين"،" لماذا " فهي تؤدي إلى نقاش مفتوح وتشجع المراجع على التحدث بصراحة.
- بشكل عام، من الأفضل استخدام الأسئلة ذات النهايات المفتوحة من أجل البدء بحوار والاستمرار به. وتبقى ايضا استخدام الأسئلة ذات النهايات المغلقة مهم في بعض الاوقات للحصول على معلومات محددة مثل" هل اشتريت دواءك من الصيدلية؟"، ومن ثم بإمكانك إتباع هذا السؤال بسؤال آخر ذو نهاية مفتوحة مثل" كيف كنت تشعر خلال هذا الشهر؟".

المهارة الثالثة: استخدم الإيماءات والتوضيح والتلخيص:

إن هذه المهارات والتي يشار إليها أيضا ب"مهارات الانتباه والإصغاء"، تبين أن العامل في المجال الصحي يصغي جيدا إلى المراجع وهذه السلوكيات تدعو المراجع إلى الاسترخاء والتحدث عن نفسه وعن مشاكله.

- **الايماءات:** يجب على المرشد النفسي أن يظهر للمراجع أنه مستمع اليه وأنه مهتم بما يقوله الأمر الذي يشجعه على الاستمرار بالحديث والمشاركة. ويتم ذلك من خلال الإيماء برأسك الى الأعلى والاسفل عند كلام المراجع والابتسام، و اصدار أصوات تدل على الاصغاء والاهتمام مثل "مممم"، "هاا"، "أها".

❑ **الإيضاح:** يمنع من حدوث أي سوء تفاهم ويساعد في فهم ما يقال. فمثلاً، إذا قال المُراجع"لا أستطيع النهوض من السرير في الصباح"، عندها قد يسأل المرشد النفسي. ما يلي" :كيف يكون النهوض صباحا أمرا صعبا بالنسبة لك؟"، أو"يبدو أنك تواجه الكثير من التحديات في النهوض صباحا, أخبرني أكثر".

❑ **التلخيص:**

- وهو تجميع مواضيع نقاش الجلسة الإرشادية النفسية بحيث يتمكن المُراجع من رؤية الصورة كاملة. كما أنه يساعد في تأكيد أن المُراجع والمرشد النفسي يفهمان بعضهما البعض.
- قم بمراجعة نقاط النقاش المهمة وقم بتسليط الضوء على أي قرار تم اتخاذه.
- قم بتلخيص النقاط الرئيسية في أي وقت أثناء الجلسة الإرشادية النفسية ليس فقط في نهايتها.
- إن التلخيص يقدم الدعم ويشجع المُراجع على تنفيذ القرارات التي اتخذوها.

المهارة الرابعة :إعادة التفكير بما يقوله المُراجع (التغذية الراجعة):

❑ التغذية الراجعة وهذا يعني تزويد المراجعة بتغذية راجعة عما قاله من أجل تشجيعه على قول المزيد. هذا يبين أن المرشد النفسي. يفهم ويقود المراجع إلى الحديث عما هو مهم بالنسبة له وإن إعادة التفكير بما يقوله المُراجع تظهر انك تصغي بفعالية، ويشجعه على الحوار، ويعطي فرصة لفهم مشاعر المُراجع بتفصيل أكبر.

❑ حاول قول ما تريد إعادته بطريقة مختلفة قليلا, مثال: إذا قالت المراجعة"لا أستطيع أن أخبر عائلتي بأنني آتي لجلسات إرشاد نفسي. "عندها يمكن أن يقوم المرشد النفسي. بإعادة صياغة الجملة بقوله"يبدو أن التحدث مع عائلتك عن الإرشاد النفسي أمر صعب عليك» ومن ثم القول" فلنتحدث بهذا الشأن."

❑ بالرغم من أن إعادة التفكير هي مهارة استماع ومعرفة مهمة، إلا أنه يجب عدم استخدامها في كل مرة ففي الحديث قم بالتنويع في الأسلوب ما بين التغذية الراجعة على الاستجابات الأخرى مثل"آها، حقا؟"، أو الأسئلة ذات النهايات المفتوحة.

المهارة الخامسة :التعاطف (تتفهم مايشعر به المراجع):

❑ ان التعاطف يختلف عن الشفقة، فعندما تشفق فإنك تشعر بالأسى على الشخص وتنظر للموضوع من وجهة نظرك أنت. بينما التعاطف (تضع نفسك بمكان المراجع) هو اظهار تفهُّمنا لمشاعر المُراجع ومايمر به وتشجعه على مناقشة القضية بشكل أكبر.

❑ على سبيل المثال، إذا قالت المُراجعة" :إن طفلي الصغير يبكي طوال الوقت وهذا يجعلني أشعر بالتعب الشديد"، بإمكان المرشد النفسي. أن تجيب"أنت فعلا تشعرين بالتعب طوال الوقت"، أما إذا قال المرشد النفسية أنا أعرف كيف تشعرين, لقد كان طفلي يبكي كثيرا عندما كان صغيرا وكان يجعلني أصُاب بالإرهاق "!هنايصبح شفقةً لأن الانتباه أصبح على المرشد النفسى وتجاربه بدلا من أن يكون على المُراجع.

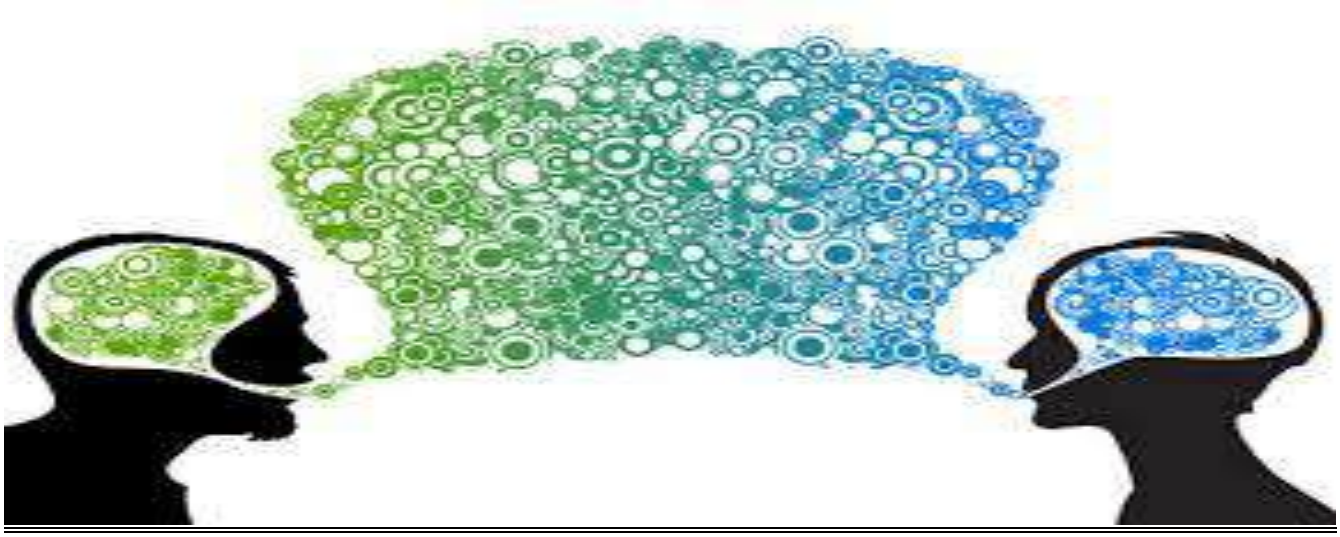
المهارة السادسة :تجنب استخدام الكلمات التي تبدو وكأنها أحكاما او تلك التي تسبب اذى للمراجع

- إن كلمات إصدار الأحكام هي كلمات مثل :صح، خطأ، جيد، سيء، كاف، مناسب.
- إذا استخدم المرشد النفسي هذه الكلمات عند طرح الأسئلة تجعل المراجع يشعر أنه على خطأ أو ان هنالك خطأ ما بطريقة تصرفها أو مشاعرها.
- كذلك تجنب نقد المراجع او لومه او مقارنته بالاخرين.

ألاخطاء الشائعة في مهارات التواصل

يسهل تعلمّ مبادئ التواصل كمفاهيم لكن يصعب تطبيقها على أرض الواقع. فهي مهارات تكتسب تدريجيا وتزداد وتعزز بالتجربة وفيما يلي نبين بعض الأخطاء الشائعة وتشمل:

- سيطرة المعالج على مجريات النقاش، بدلا من تشجيع المراجع على التعبير عن مشاعره واحتياجاته بحرية.
- إصدار أحكام على المُراجع مثل قول جمل توحي بأن المُراجع لا يرقى لمستوى معايير المرشد النفسي.
- تقديم الوعظ للمُراجع: مثل إخبار المُراجع كيف يجب أن يتصرف أو قيادة حياته كقول "حسناً يبدو أنك قد تسببت لنفسك بمشكلة كبيرة»
- إطلاق ألقاب على المُراجع بدلا من معرفة دوافعه الفردية ومخاوفه والأمور التي تسبب له القلق.
- طمأنة المُراجع دون معرفة وضعه الصحي مثلاً أن تخبر المراجع "لا يوجد أي داع للقلق."
- عدم تقبل مشاعر المراجع مثل قول "يجب أن لا تغضب بسبب هذا الأمر."
- إسداء النصيحة قبل أن يجمع المُراجع معلومات كافية أو يستغرق الوقت الكافي بالنسبة له للخروج بحل شخصي.
- الاستجواب والتحقيق مثل طرح أسئلة اتهامية. إن الأسئلة التي تبدأ بالكلمة "لماذا" تبدو وكأنها اتهامية .
- تشجيع الاعتماد والاتكالية مثل زيادة حاجة المُراجع لوجود المرشد النفسي وتلقي الإرشادات منه.
- الإقناع أو التملق مثل محاولة جعل المُراجع قبول سلوك جديد بإطرائه أو تزييفه. "أعرف أنك فتاة ذكية وأنك ستأتين لجلسات إرشاد نفسية كما أخبرتك."



٣) معرفة أسس المقابلة حيث تتطلب المقابلة السليمة الخطوات التالية:

- ❑ **التحية والترحيب واظهار الاحترام الحقيقي للمستفيد.**
- ❑ **نعرّف الشخص بأنفسنا:** اكثر المراجعين يشعرون بالقلق والشكّ، لذا علينا أن نبين دورنا المهنيّ بوضوح ونقول إنّنا نرغب في التحدّث عن صحّة الشخص وطَمأنتهُ بأنك ستعمل لمساعدته بطرق علمية.
- ❑ **نحرص على خصوصيّة المقابلة:** قد يكون صعباً في العيادات المكتظّة، ولكن يمكننا أن نتحدّث بهدوء وبصوت منخفض فلا يستمع الآخرون في الغرفة إلى مناقشة الأمور الشخصيّة. كذلك يمكننا أن نطلب إلى الشخص الانتظار إلى أن تصبح العيادة أقلّ ازدحاماً لنكلّمه على انفراد.
- ❑ **استأذان المستفيد للموافقة على بدء المقابلة،** وأكد له أن المعلومات ستبقى سرية ولن يطلع عليها أحد.

- **إزالة الحواجز وبناء الثقة مع الفرد:** يمكن أن نبدأ المقابلة بموضوع عامّ، مثل حدث جرى مؤخّراً في حياته. فعددٌ كبير من الأشخاص يشعرون براحة أكبر حيال مناقشة قضاياهم الشخصيّة، اي محاولة خلق قاسماً مشتركاً بينهم وبين مقدم الخدمة، خاصة اذا يتكلّم اللغة نفسها أو يسكن في المنطقة نفسها ويكون مهني.
- **طرح الأسئلة الجوهريّة على المريض:** في كلّ مرّة يلقى سؤالنا ردّاً إيجابيّاً علينا أن نتقدّم أكثر في عمليّة الفحص، ومن الضروري الحفاظ على السرية، واحترام معتقدات الشخص الثقافية والاجتماعية والدينية، ومن المفيد دائماً أن نتذكّر الأنواع الأساسيّة للاضطرابات النفسيّة وأعراضها , خصوصا ان أشخاصاً كثيرين قد لا يفاتحوننا بمشكلاتهم العاطفيّة إلا إذا سئلوا عنها مباشرةً.
- **الاصغاء التام والنظر إلى الشخص في أثناء المقابلة:** فالاصغاء والتواصل البصريّ يعطيه الثقة بأنّ مقدم الخدمة مهتمٌّ لما يقوله.
- **التعاطف مع المراجع ومشاركته وجدانياً:** علينا ببساطة أن نتخيّل ما يمكن أن نشعر به لو كنا مكانه. وسيساعدنا فهم الأعراض التي يشكو منها الشخص ووضعه الاجتماعيّ والعائليّ في معالجة المرض بدقّة أكبر، ويساعد الشخص في التحدّث إلينا براحة أكبر.
- **نعطي الشخص فرصةً للتكلّم في غياب الأقرباء:** ولا نعتبر أبداً أنّه شخص لايعتمد عليه لمجرد انه مضطرب نفسيا.
- **نسعى للتحدّث إلى الأقرباء أيضاً:** فبعض الأشخاص قد ينكر أنه يعاني أيّ مشكلة. ولا يدرك البعض منهم أيضاً طبيعة تصرّفاتهم. لذا فإنّ الأقرباء والأصدقاء قد يعطون معلومات تفيد في اتخاذ قرار تشخيصي., ولكن يجب التذكر دائما بمبدأ سرية المعلومات بين المراجع والمرشد وعدم البوح بها لاي شخص ثان.ولابد من موافقة المراجع قبل التحدث مع الاخرين حول حالته او مشاكله او اية أمور تخصه.
- **يجب ألا نبدو مستعجلين:** فننظر إلى الساعة باستمرار مثلاً. أنّنا لن نحتاج عادةً إلى أكثر من عشر.دقائق لفهم مشكلة الشخص ومعرفة الخيارات العلاجيّة. وإذا خصّصنا له المزيد من الوقت فسيكون ذلك أفضل، فالشعور بالثقة والاهتمام أثناء العمل مع الشخص يساهم في تحسّن حالته.
- **ندوّن المعلومات الأساسيّة لاستعمالها مرجعاً في المستقبل:** ولا سيّما الأعراض الأساسيّة، والتشخيص الحاليّ، وأيّ معلومات هامّة، مثل المشكلات الزوجيّة, ويتم ذلك خلال حديثنا نحن وليس اثناء كلام المراجع.

ما ينبغي ايضا ملاحظته أثناء المقابلة؟

في أثناء المقابلة ينبغي أن نلاحظ ما يأتي:

- **تعابير الوجه:** (قد تكون تعابير الوجه دالّة على حزن أو خوف)
- **الحركة الجسدية:** (ن كان هناك بطء أو زيادة في الحركة). فقد يعاني الشخص من كثرة الحركة، أي عدم القدرة على الجلوس والاسترخاء (في حال القلق والذهان والاكتئاب والإحباط وإدمان الكحول والمخدّرات أو نتيجة الآثار الجانبيّة لبعض أدوية الأمراض النفسيّة والعقليّة). او حركات غريبة (في حال الفصام أو نتيجة الآثار الجانبيّة لبعض أدوية الأمراض النفسيّة والعقليّة).
- **الكلام والتفكير:** وتيرة سريعة جدّاً في الكلام (في حالات الذهان، ولا سيّما الهوس), او وتيرة بطيئة جدّاً في الكلام (في حال الاكتئاب وإدمان المخدّرات والفصام).
- **الاعتناء بالمظهر والنظافة الشخصيّة:** (ضئيلة في حال الاكتئاب وإدمان الكحول والمخدّرات والفصام).

الانتباه الى الحالات الخاصة في المقابلة

❖ مقابلة شخص يرفض الكلام

- قد يكون غاضباً لأنّه أحضِر إلى العيادة,
- أو خائفاً من أن يُسمّى مريضا نفسيا ويوصم ان تحدّثعن شكواه إلى المعالج.
- أو انه غير واثق او مطمأن من دوافعنا اتجاه.

الأجراءات التي قد تساعد الشخص على الشعور بثقة أكبر حيال مناقشة مشكلاته.

- نعطي الشخص مزيداً من الوقت
- نقابله في غرفة على انفراد
- نطلب من مرافقيه الوقوف بعيداً بشكل لا يسمعوا الحديث
- نطمئن الشخص الذي يرفض الكلام إلى أنّنا مهتمُّون لمشكلاته
- لا نهدّد الشخص، بقولنا مثلاً إنّنا لا نرغب في إضاعة وقتنا
- اما إذا استمر في رفض الكلام فنقول إنّنا سنذهب ونعود بعد برهة من الزمن لاكمال حديثنا وبذلك نعطي الشخص وقتاً إضافيّاً للتفكير ويظهر له اهتمامنا. وفي حالة انه استمر بعد ذلك بعدم الحديث فاننا لانغلق الابواب امامه بل نوضح له بان ابوابنا مفتوحة له في اي وقت يراه مناسبا للقدوم والحديث معنا فان غايتنا خدمته وتقديم مايساعده على تجاوز ازمته.

❖ مقابلة شخص يعاني من شكاوى جسدية ومعروف بانه يعاني اضطراباً نفسياً

- وهي تحدث عندما يحضر شخص معروف مسبقا انه مضطرب نفسيا إلى المركز ويشكو من أعراض جسدية, مثلا ألم في الرأس. وعادة ما يعتبر العاملون الصحيّون هذه الشكاوى عارضاً غير مهم او انها نتاج الاضطراب النفسيّ, وهذا قد يؤدي إلى **إغفال مرض جسدي خطير** فلذلك علينا عدم تجاوزْ الشكاوى الجسدية الجديدة من دون تقييمها كما يلزم وضرورة اعطاء الصحّة الجسدية للمضطرب نفسيّا الاهتمامَ الكافي.
- تذكّرْ أنّ المرضى النفسيون غالبا مايهملون صحّتهم الجسدية.
- وترتبط بعض المشكلات الصحيّة النفسيّة ارتباطاً وثيقاً بمشكلات الصحّة الجسدية، وأبرز الأمثلة على ذلك هي:
  - إدمان الكحول والمخدّرات الذي يمكن أن يضرّ كثيراً بالصحّة البدنية.
  - النساء اللواتي تعرّضن للعنف أو للاغتصاب.
  - التشوش والاضطراب اللذان ينتجان من مشكلات في الصحّة البدنية.
  - السلوك غير الملائم عند كبار السنّ.

❖ مقابلة شخص قد يكون عنيف

- ان طبيعة الأفراد الذين يعانون اضطراباً نفسياً ليسوا عنيفين وأنّهم يصبحون عنيفين لعدّة أسباب منها:
  - عندما يسمع الشخص أصواتاً (الذهان)
  - عندما يعيقه أمرٌ ما عن تحقيق مشاريعه وأحلامه (الهوس)
  - عندما لا يمكنه أن يحصل على الكحول و المادة الادمانية في الوقت المناسب.
  - الشخص المشوش (يشعر بالخوف وبحاجة إلى الدفاع عن نفسه تجاه اناس غرباء).
- أبرز المشكلات الصحية النفسية التي ترتبط بالعنف هي حالات الذهان، وإدمان الكحول والمخدّرات.

نصائح للمقابلة

- **ان نكون حذرين من مؤشرات العنف الوشيك**
  - يرتفع صوته ويصبح خطيراً أو يهدّد.
  - يفتح قبضته ويغلقها تكراراً.
  - يتنفّس بسرعة.
  - ينفعل ويتململ.
  - يضرب بيده أو بقبضته على الطاولة أو الحائط أو الأرض.
- **نراقب مؤشّرات التسمّم بالمواد الكيميائية او بالكحول أو بالمخدرات.**
  - ننتبه إلى رائحة الكحول أو آثار الحقن على جلده (مؤشر لتعاطي المخدرات).
  - ننتبه الى حديث الشخص ان لم يكن منطقيّاً أو أصبح سريعاً جدّاً او بأن الشخص يفقد التوازن ويتكلم بشكل متقطّع وغير واضح.

الاجراءات:

- نصغي إلى مشاعرنا. إذا شعرنا بالخوف، نوقف المقابلة ونحاول فهم مشاعرنا وأسبابها والتعامل معها.
- نحرص على أن يكون باب غرفة العيادة سهل البلوغ لنا.
- نتكلم بنبرة واضحة وهادئة ولا نصرخ ونحاول تهدئة الشخص.
- لا نهدّد الشخص ابدأ، فهذا سيزيد الحالة سوءاً ليس إلا.
- نضع عامل صحي آخر في أثناء المقابلة. وإذا استحال ذلك، نطلب من أحد الأقرباء أو الأصدقاء الموثوق بهم أن يجلس معنا إذا وافق على ذلك المريض.
- إذا كان الشخص يحمل سلاحاً، نطمئنه إلى أننا ملاكات صحية ولا حاجة إلى سلاح في العيادة. وإذا رفض تسليم السلاح، نترك الغرفة ونتصل بجهاز الأمن المختص لينزع سلاحه.
- إذا أصبح الشخص عنيفاً، نحاول أوّلاً أن نساعده على أن يهدأ بينما نطمئنه بثقة. وإذا لم نتمكن من ذلك، فننهي المقابلة ونحيله الى الاستشاريات النفسية.
- السلوكيات العنفية لذلك الشخص بالتاكيد تؤثّر دائماً على الأقرباء والأصدقاء. ينبغي أن نقلق بشأن سلامة الآخرين، ونقدّم الإرشاد للأشخاص الذين تأثروا بذلك وأن نوضح طبيعة الحالة ما سنفعله ولماذا لكن يبقى هدفنا الأساسيّ هو في حماية الشخص نفسه وفهمه ومساعدته.

❖ **مقابلة شخص بحضور اسرته**

- القاعدة السليمة هي أن نمنح الشخص فرصة التحدّث إليه على انفراد للتعرف على العلاقات والضغوطات في داخل الأسرة, مع العلم ان الأسرة تلعب دور كبيرة في تقييم وعلاج الأشخاص المضطرابين نفسيّاً. ولكن يجب تحقيق التوازن بين الحاجة إلى إشراكهم في عمليّة الفحص من جهة أخرى والحاجة إلى ضمان خصوصيّة المريض من جهة اخرى.
- يمكن مناقشة المشكلة في ما بعد مع أفراد الأسرة, و نحرص على ألا نناقش الأمور التي طلب المريض أن تبقى سريّة.
- تعتبر الأسرة عنصر أساسيّ للحصول على معلومات عن الشخص. فالأشخاص الذين يعانون الاضطرابات النفسيّة الشديدة أو الإدمان مثلاً لا يستطيعون إعطاء وصف واضح ودقيق للحالة بل يمكن أن يزوّدنا الأقرباء بالمعلومات اللازمة للتوصّل إلى تشخيص.
- ايضا للأقرباء دورٌ مهم في الاعتناء بصحّة الشخص وتقديم الدعم والاسناد له وتشجيعه على تناول الأدوية الموصوفة.

❖ **مقابلة شخص يفكر في الانتحار أو سبق أن حاول الانتحار:**

ماهي الاضطرابات النفسية المرتبطة بالانتحار:

- الإكتئاب. هذا هو السبب الأهم للانتحار. فالاكتئاب يدفع بالشخص إلى الشعور بالبؤس والاحباط، وفقدان الاهتمام بالحياة، وفقدان الأمل في المستقبل.
- إدمان الكحول والمخدرات. حيث أنّ لهذه المواد تأثير إحباطي على الدماغ. كما إن فقدان الأمل في أن يقدر الشخص على أن يضع حدّاً للإدمان، بالإضافة إلى المرض الجسدي والمشكلات المادية، كلها عوامل تدفع بالشخص إلى الرغبة في الانتحار.
- المشكلات الصحية طويلة الأمد وتلك التي تسبّب الألم أو التي لا حلّ لها تدفع بالشخص إلى الرغبة في الانتحار.
- الاضطرابات النفسية الحادة. الأشخاص المصابون بذهان معرّضون لخطر الانتحار.
- العوامل الاجتماعية والشخصية التي قد تدفع بالشخص إلى الانتحار:
  - العلاقات غير السعيدة، ولا سيّما الزواج غير السعيد.
  - الفقر والصعوبات الاقتصادية، وخصوصاً عندما تطرأ فجأة.
  - فقدان شخص عزيز، او خسارة علاقة عاطفية حادة.
  - عدم توفّر الأصدقاء الذين قد يشاركهم الشخص مشكلاته ومشاعره.
  - المراهقون عندما يرسبون في المدرسة أو يتشاجرون مع أهلهم في المنزل.

الاجراءات:

- ان سؤال الشخص عن الأفكار الانتحارية، لايدفعه على الانتحار، بل على العكس، معظمهم سوف يشعر بالارتياح. على ان يتم السؤال بطريقة سلسة وبالتدريج كان يتم سؤال المراجع عن رأيه في الحياة او هل تتساوى الحياة والموت بنظره او هل فكر او ربما يتمنى لو انه ينام ولايستيقظ بعدها ,ان كانت الإجابة نعم فيكون السؤال المباشر كالاتي : قد يعاني الكثير من الناس حول العالم من مشاكل او صعوبات قد تدفعهم الى التفكير او محاولة إيذاء النفس او القدوم على الانتحار فهل راودتك مثل هذه الأفكار وهل تفكر في انهاء حياتك؟
- اخذ الافكار الانتحارية محمل الجد, ولا نستهزء بها أبداً.
- نتحدّث إلى الأسرة أو الأصدقاء لنعرف كيف كانت حياته وحالته الصحية من وجهة نظرهم.
- نحتاج إلى بناء علاقة ثقة مع أحد افراد الاسرة او الاصدقاء لكي يقدم له الدعم في البيت.
- نعطيه الوقت الكافي ليستعيد هدوءه واتزانه والتأكد من ذلك قبل المغادرة.
- نطلب منه دائماً أن يأتي إلى العيادة لرؤيتنا.
- في حال الشك بنية الانتحار بالرغم من الإرشاد, نعطي الشخص فرصة مفتوحة للتواصل معنا عندما يشعر بالاكتئاب واحالته الى الاختصاص
- في حالات وجود محاولة انتحارية نحرص اولا على أنقاذ حياته (علاج طبيّ طارئ) إذا كان قد تناول جرعة مفرطة من الحبوب أو شرب السم أو جرح نفسه جرحاً بالغاً.
- ينبغي أن يبقى الشخص دائماً برفقة شخص آخر، ونطلب من الأقرباء أن يبقوا معه ونحرص على ألا يُترك وحده بُعَد محاولة الانتحار.
- نحرص على أن تبقى كل الأدوات المؤذية، او السموم أو السكاكين، بعيدةً عنه.
- ثم الاحالة الى الاختصاص.

الفصل الثاني

❖ المرحلة الثانية (التقييم)



كيف نتوصّل إلى تشخيص الحالة؟

- ❑ علينا أن نتمرّن على مهارات التواصل واسس المقابلة أوّلاً مع زملائنا.
- ❑ يجب أن نعرف جيّداً أنواع الاضطرابات النفسيّة الشائعة والأسئلة الاساسية التي تُطرح لتقييم الصحّة النفسيّة.
- ❑ ينبغي الاعتماد على تشخيص الاضطرابات النفسية الشائعة في أماكن تقديم الرعاية الصحيّة الاولية.
- ❑ تحديد المشاكل التي يعاني منها المراجع (كأن تكون مشاكل عملية او عدم القدرة على اتخاذ قرار, او مشاكل نتيجة لمشاعر غامرة, او مشاكل ناتجه عن التعرض لصدمة حادة اومشاكل ناتجة عن افتقار المراجع لمهارات حياتية محددة) وبالتالي العمل على اختيار نوع التدخلات في المرحلة القادمة بناءا على نوع المشكلة التي يعاني منها المراجع ومساعدته الى اكتشاف امكانياته وتوسيع نظرته لايجاد الحلول الممكنه بنفسه.

١) السمات الرئيسية لأهم الاضطرابات النفسية

- ان الأداة الرئيسيّة للتشخيص هي إجراء **مقابلة** مع الشخص المعني.
- وان الكشف عن الاضطراب النفسي وتشخيصه يعتمد كليّاً على ما يبلغنا به المريض والقريبين منه.
- ان الاضطراب النفسي يحدث أعراضاً يلاحظها الذين يعانونه او القريبون منهم, وترتبط هذه الأعراض ارتباطاً وثيقاً بعضها بالبعض الآخر, ومن الممكن حدوث أعراض مختلفة في الشخص نفسه.
- **على الملاكات الطبية والصحية العاملة في مجال تقديم خدمات الصحة النفسية معرفة اهم السمات الرئيسية لاهم الاضطرابات النفسية لكي يكون متمكن في تقييم المريض النفسي وتدبير حالته.**

اهم المؤشّرات الدالّة على وجود اضطراب نفسيّ

- إذا كان في سجلّ الشخص أو عائلته مرض نفسيّ سابق.
- وجود اسباب مباشرة للاضطراب النفسي.
- عندما يعطي الشخص أو أقاربه أعراضا غير طبيعية.
- عندما يلحظ الاهل او التربوي على الطفل اضطراب سلوكي او نمائي.

- عندما نعرف أنّ الشخص يعاني مشكلات حياتية، مثل البطالة أو وفاة صديق حميم.
- عندما نعرف أنّ لدى الشخص مشكلات مرتبطة بالعلاقات، مثل المشكلات الزوجيّة أو الجنسيّة.
- عندما يشكو المريض من عدّة آلام جسديّة لا تندرج في إطار مرض جسدي واحد معروف.
- وجود مشكلات ناتجة عن عنف المنزلي او ادمان وكذلك شرب الكحول.
- عندما يكون هنالك تدهور ملحوظ في الأداء الوظيفي اوالاجتماعي او الدراسي.

❑ **<u>هناك خمسة أنواع رئيسيّة من الأعراض للاضطراب النفسي:</u>**

- **اعراض جسدية:** وهذه تؤثّر على الجسم والوظائف الجسدية، وتشمل الآلام والتعب وصعوبات في النوم...وغيرها. نؤكد دوما أنّ الاضطرابات النفسية قد تُنتج أعراضاً جسدية.
- **اعراض ادراكية:** كالافكار الانتحارية, والاعتقاد بأنّ أحدهم سيؤذيهم (ضلالات فكرية)، وصعوبة التفكير بوضوح، والنسيان. او اعراض تنشأ من أحد أعضاء الحواس وتشمل سماع الأصوات أو مشاهدة أشياء لا يستطيع أن يراها الاخرون (هلوسات)
- **اعراض عاطفية (إنفعالية):** الأمثلة النموذجيّة هي الشعور بالحزن أو الخوف.
- **اعراض السلوكيّة:** تتعلّق هذه الأعراض بما يقوم به المرء من سلوكيات وتشمل التصرّف بطريقة عدوانيّة ومحاولة الانتحار.
- **عجز في الاداء الوظيفي او المجتمعي:** وهي تدهور اداء الفرد في انجاز وظائفه الفردية و ارتباطاته الاجتماعية.

<u>السمات الرئيسية للاكتئاب</u>

❑ **الاعراض الجسدية:**

- تعب وشعور بالإنهاك والضعف.
- الخمول وفقدان الطاقة.
- أوجاع غامضة وآلام بكل أنحاء الجسم.
- الصداع والتعب لأقل مجهود.
- فقدان الشهية ورفض الطعام و انخفاض واضح في الوزن لا يمكن تفسيره بحمية غذائية ، أو العكس زيادة في الشهية للطعام وزيادة ملحوظة في الوزن.

❑ **الاعراض الادراكية:**

- اليأس بشأن المستقبل.
- صعوبة اتخاذ القرارات.
- أفكار بالاختلاف عن الآخرين وتدنّي الثقة بالنفس.
- أفكار متكررة بالرغبة بالموت الموت (لا يشمل ذلك الخوف من الموت) ، أفكار انتحارية متكررة.
- عدم القدرة على التفكير أو صعوبة في التركيز أو اتخاذ القرار.

❑ **الاعراض السلوكية:**

- اضطراب في النوم (قلّة او زيادة في النوم) (أرق أو ميل للنوم).
- لانطواء والانسحاب والوحدة و الانعزال والصمت
- ضعف الشهيّة او ازدياد الشهيّة.
- انخفاض الشهوة الجنسيّة.

❑ **الاعراض العاطفية:**

- شعور بالحزن والبؤس ومزاج مكتئب أو حزين أو تعيس.
- نقص واضح في الرغبة أو المتعة في كل الأشياء التي كانت تثير الرغبة أو المتعة .
- فقد الاهتمام بالحياة والتفاعل الاجتماعيّ والعمل، إلخ.
- الشعور بالقلق والتوتر وعدم القدرة على الاسترخاء أو شعور بالبطء والتثاقل الجسمي.
- الإحساس بالدونية، ولوم النفس أو الشعور بالنقص.
- الشعور بالذنب واتهام الذات.

السمات الرئيسيّة للقلق النفسي

❑ **الاعراض الجسدية:**

- الشعور بسرعة نبض القلب (خفقان).
- شعور بالاختناق.
- دوار.
- ارتعاش، رجفة في كل الجسم.
- صداع.
- وخز في الأطراف أو الوجه (شعور بالتنمّل الخدر).

❑ **الاعراض الادراكية:**

- القلق كثيراً بشأن مشكلاته أو صحّته.
- أفكار بأنّه سيموت أو يفقد السيطرة أو يجنّ (غالباً ما ترتبط هذه الأفكار بأعراض جسدية حادّة وخوف كبير).
- تكرار التفكير بالخوف والحزن على الرغم من محاولات وقف التفكير به.

❑ **الاعراض العاطفية:**

- الشعور بأنّ شيئاً رهيباً سيحدث.
- الشعور بالخوف.

❑ **الاعراض السلوكية:**

- تجنّب الأوضاع التي يخشاها، مثل قيادة السيارة أو النقل العام.
- النوم السيء.
- النرفزة (سرعة الانفعال) لأمور قد تبدو تافهة بنظر الاخرين.
- الجفلة (رد فعل سريع وغير متوقع لمنبهات بسيطة كانغلاق الباب)

ملاحظة عن القلق النفسي:

❑ يعاني معظم الأشخاص المصابين باضطراب نفسي مزيجاً من أعراض الاكتئاب والقلق.

❑ القلق النفسي لايوجد سبب واضح له ولا يمكن التحكم في ايقاف الشعور به.

❑ القلق النفسي يختلف عن الشعور بالقلق والعصبية التي تسبق حدوث شيء معلوم.

❑ الخوف الطبيعي: عادةً ما يكون من مصدر خارجي ويجعل الجسم مستعداً للتصرف إما عن طريق الفرار من الموقف أو حماية نفسه باستخدام القوة الجسدية. (حسب قاعدة الاستجابة الفسيولوجية " قاتل او أهرب")

❑ يختلف الخوف الطبيعي عن الرهاب لان الرهاب هو عبارة عن خوف شديد جداً وغير مبرر من أمرٍ ما، أي عندما يكون رد فعل الخوف أكبر مما يتطلبه الموقف أو مما يتحمله الانسان فيصبح مشكلة.

الدلائل البارزة على الفصام

- **الأعراض الجسدية:**
  - شكاوى غريبة، مثل الشعور بأنّ حيواناً أو أجساماً غير عاديّة موجودة في داخل جسد المريض.
- **ألاعراض الادراكية:**
  - صعوبة في التفكير بوضوح, مع فقدان للبصيرة في إمكانية ان يكون هو مضطربا نفسيا.
  - أفكار غريبة ثابتة لايمكن ان تتزحزح، مثل الاعتقاد أنّ الآخرين يحاولون إيذاءهم أو أنّ قوى خارجيّة تتحكّم بذهنهم (ضلالات).
  - سماع أصوات تتكلّم عنهم، ولاسيّما أصوات شرّيرة (هلوَسات سمعية)
  - رؤية أشياء لا يراها الآخرون (هلوَسات بصرية).
  - او هلاوس أخرى كالهلاوس الحسية او الشمية.
- **ألاعراض الانفعالية:**
  - الاكتئاب.
  - فقدان الاندفاع والاهتمام بالنشاطات اليوميّة.
  - الشعور بالخوف من التعرّض للأذى.
- **ألاعراض السلوكيّة**
  - الانقطاع عن تأدية الأنشطة اليومية.
  - الحركة الزائدة والمستمرة.
  - السلوك العدوانيّ.
  - السلوك الغريب مثل الاحتفاظ بالنفايات.
  - عدم الاعتناء بالمظهر وبالنظافة الشخصيّة.
  - إعطاء إجابات خارجة عن موضوع الأسئلة.

الدلائل البارزة على الهوَس

- **ألاعراض الادراكية:**
  - الاعتقاد أنّهم يتمتّعون بقوى خارقة أو بأنّهم أشخاص مميّزون.
  - الاعتقاد أنّ الآخرين يحاولون إيذاءهم.
  - إنكار مرضهم إنكاراً مطلقاً.
  - سماع أصوات لا يسمعها الآخرون (وغالباً ما تخبرهم هذه الأصوات أنهم أشخاص ميّميزون يمكنهم القيام بأمور عظيمة).
- **ألاعراض العاطفية (الانفعالية):**
  - الشعور بأنّهم أعلى من العالم كلّه.
  - مزاج عالي مع الشعور بالفرح من دون أيّ سبب.
  - حدّة الطبع وسهولة الانزعاج.
  - الإحساس بامتلاك طاقة عالية
- **ألاعراض السلوكيّة:**
  - السرعة في التكلّم.

- قلّة المسؤوليّة الاجتماعيّة، بما في ذلك السلوك الجنسيّ غير اللائق.
- عدم القدرة على الاسترخاء أو القعود من دون حركة.
- قلّة النوم. وايضا رفض العلاج.
- محاولة إنجاز أمور كثيرة والفشل في إتمام أيّ منها.

الدلائل البارزة على إدمان الكحول

- **ألاعراض الجسدية**
  - مشكلات في المعدة، مثل التهاب المعدة أو القرحة.
  - أمراض الكبد واليرقان.
  - تقيُّؤ الدم.
  - التقيُّؤ أو الغثيان في الصباح.
  - الرجفة، ولاسيما في الصباح.
  - الحوادث والإصابات.
  - ردود فعل انقطاعيّة، مثل النوبات المرضيّة، والتعرّق، والتشوّش.
- **ألاعراض الادراكية:**
  - رغبة قويّة في شرب الكحول.
  - التفكير المستمرّ في المناسبة التالية للشرب.
  - التفكير في الانتحار.
- **ألاعراض إلانفعالية:**
  - الشعور بالضعف وبعدم القدرة على السيطرة على الذات.
  - الشعور بالذنب حيال شرب الكحول.
- **ألاعراض السلوكيّة**
  - صعوبة في النوم.
  - الحاجة إلى شرب الكحول في ساعات النهار.
  - الحاجة إلى شرب الكحول في الصباح الباكر للتحرّر من الانزعاج الجسدي.

الدلائل البارزة على إدمان المخدّرات

- **ألاعراض الجسدية**
  - مشكلات في التنفّس، مثل الرّبو.
  - التهابات في الجلد، والقرحة عند الحقن الوريدي للمخدرات.
  - ردود فعل غير طبيعيّة في حال الانتقطاع عن تناول المخدّر، مثل الغثيان, والرجفة، والإسهال، وتشنّج المعدة، والتعرّق.
- **ألاعراض الادراكية:**
  - رغبة قوية في تناول المخدّر.
  - التفكير المستمرّ في المناسبة التالية لتناول المخدّر.
  - التفكير في الانتحار.

❑ **ألاعراض الانفعالية:**

- الشعور بالضعف وبعدم القدرة على السيطرة على الذات.
- الشعور بالحزن والاكتئاب والذنب حيال تناول المخدرات.

❑ **ألاعراض السلوكيّة:**

- صعوبة في النوم.
- حدّة الطبع التي تتجلّى في سرعة الانفعال.
- سرقة المال لشراء المخدّرات، والتورّط في مشكلات مع العدالة.

٢) معرفة المرشد بالمعلومات التي ينبغي جمعها من الفرد الذي يحتمل أنه يعاني من اضطراباً نفسيّا

❑ **معلومات عامّة**

- الجنس
- العمر
- المهنة
- الوضع العائلي

❑ **معلومات عن الشكوى الحاليّة**

- متى وكيف بدأت؟
- هل تزداد سوءاً؟
- هل يتناول دواءً أو يتّبع علاجاً آخر.
- ما هي فكرة الشخص عن اضطرابه؟ وما سببه؟ يمكننا أن نطرح أسئلة عن الأفكار المتعلّقة بالضغط أو العوامل فوق الطبيعية المؤدّية إلى المرض.
- الاعراض الجسدية
- الاعراض الادراكية
- الاعراض الانفعالية
- الاعراض السلوكية
- الاداء الوظيفي والمجتمعي

❑ **السجل النفسي:**

هل في سجلّ الشخص اضطراب نفسيّ سابق؟ إذا كان الجواب نعم، فنسأل عن الأدوية التي وصفت له، أو عن الملاحظات السريريّة السابقة.

❑ **السجلّ الطبيّ او احداث متعلّقة**

مثل إصابة في الرأس مثلاً. الأحداث الحياتيّة التي جرت مؤخراً، من انفصال، أو وفاة فرد من العائلة، أو خسارة وظيفة.

اي اننا نتحقق من الاسباب التالية:

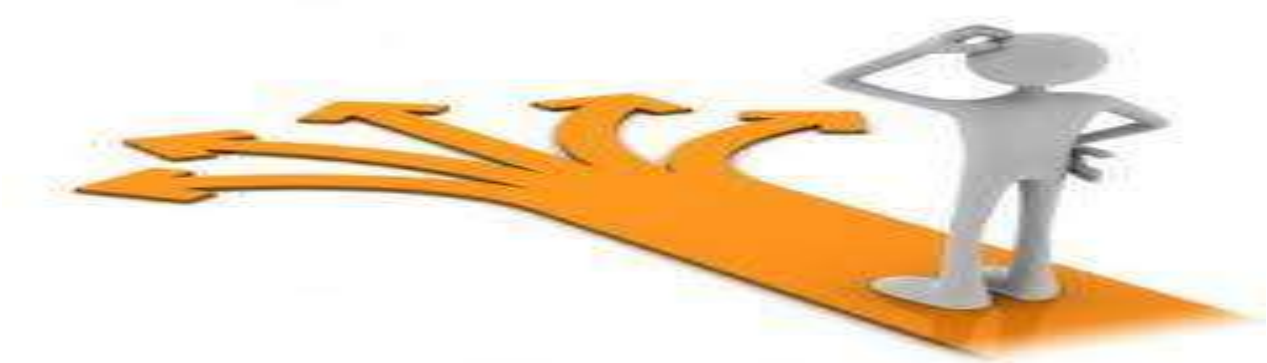
- الاسباب الممهدة للاضطراب النفسي
- الاسباب المرسية للاضطراب النفسي
- الاسباب المديمة للاضطراب النفسي
- التقصي من وجود حالة تعاطي اوادمان وكذلك وجود لافكار انتحارية او محاولات انتحارية سابقة.

❑ **الدعم الاجتماعي المتوفر:**

وبصورة خاصّة، مَع من يعيش الشخص؟ من يرعاه؟ وهل من دعم من خارج المنزل، أي دعم من نوع دينيّ أو روحيّ أو من الأصدقاء او اي دعم اجتماعي اخر متوفر؟

الفصل الثالث

❖ المرحلة الثالثة (تحديد الاهداف)



ما يجب أن نتذكره حول علاج الاضطرابات النفسيّة

❑ انه يمكن معالجة معظم الاضطرابات النفسيّة البسيطة والتي تشكل مانسبته (٩٠%) من مجمل الاضطرابات النفسية على يد ملاك طبي او صحي في الرعاية الصحية الاولية مدرب بشكل جيد على تقديم خدمات الصحة النفسية.

❑ إنّ أدوية الأمراض النفسيّة فعّالة وآمنة إذا استخدمت بالطريقة المناسبة من قبل طبيب مدرب على الدليل العالمي لراب الفجوة في الصحة النفسية.

❑ ضرورة الالتزام بترشيد استخدام الدواء. فالكثير من الأدوية النفسية تسبب الإدمان فضلاً عن آلاثار السلبية للدواء. لذلك ينبغي اللجوء إلى الإرشاد والمساندة كخيار اول وحصر.استخدام الأدوية النفسية بالحالات الشديدة التي تتطلّب ذلك, مع تزويد المريض أو مقدمي الرعاية بكافة المعلومات المتعلقة بالدواء.

١) ينبغي معرفة الحالات التي ينبغي اللجوء فيها إلى اخصائيّ الصحة النفسيّة فيها والتي تشمل:

- إذا كان الشخص مضطرباً جدّاً (اضطراب شديد (ذهاني)).
- إذا كان الشخص يتناول كميات كبيرة من الكحول أو المخدّرات، لأنّ التوقف عن تناول هذه المواد فجأة قد يؤدّي إلى ردود فعل انقطاعيّة.
- إذا كان الشخص طفلاً وتشك في أنّه يعاني من تأخر عقلي أو أيّ مشكلات دماغيّة أخرى.
- عندما يكون الشخص مضطربا نفسيا ونتأكّد من أنه مصاب بمرض جسدي، مثل إصابة في الرأس أو حرارة مرتفعة.
- في حالة وجود افكار انتحارية ثابتة او محاولات انتحارية.
- إذا استمرّ اضطراب الشخص بالتأثير على حياته الشخصية أو على عمله، بالرغم من تدخلاتنا العلاجية له.

٢) تحديد الاتجاهات او الاهداف للفرد و للمرشد التي ينبغي العمل عليها لمعرفة إذا كان الإرشاد يسير بشكل جيد ومتى ننهي العملية الإرشادية. ويعتمد ذلك على عدّة عوامل منها:

- نوع الاضطراب أو المشكلة التّي يعاني منها الشخص،
- شدّة الأعراض ومدى التوتّر الذي يمرّ به الشخص،

- المدّة التي يعاني منها المريض من الأعراض أو من المشكلة،
- ما هو الدعم الذي يتلقّاه من أفراد عائلته والأشخاص الآخرين من حوله.
- وعي المريض اتجاه مشاعره وأفكاره ومعتقداته حول هذه الاضطراب او المشكلة التي يعاني منها.

الفصل الرابع

❖ المرحلة الرابعة (التدخلات)



❖ **التدخلات التي يتضمنها العلاج الإرشاديّ على مستوى الرعاية الصحية الاولية**

- ❑ طمأنة الشخص,
- ❑ نعطي الشخص تفسيراً للوضع,
- ❑ نعطي النصائح للشخص عن أعراض معيّنة.
- ❑ تخفيف الضغوط النفسية وتعليم اساليب التخيل و تمارين الاسترخاء والتنفس العميق.
- ❑ تعليم مهارات ادارة المشكلات.
- ❑ العلاج السلوكي المعرفي بالنسبة للباحثين النفسين ان وجدوا.

١) طمأنة الشخص المضطرب نفسياً

- ❑ معظم العاملون الصحيون يعتبرون المشكلات النفسية ليست بالمشكلات الطبية الحقيقة ولايعطونها الاهتمام الكافي.
- ❑ ليس من الصحيح ان نقول للشخص (انت لاتشكو من شئ), لأنّ معظم الأشخاص يغضبون لهكذا تفسير لانهم فعلا يشكون من شيء ما, وكثيرون يخافون من أن يكونوا مصابين بمرض خطير.
- ❑ هكذا تفسير يزيد من توتّرهم ومعاناتهم, لذلك ينبغي أن نطمئن الشخص إلى أننا نفهم أنه يعاني من اعراض مزعجة، وانها يمكن تفسيرها وايجاد الحلول لها, وهي ليست بالامر الخطير.
- ❑ علينا أن نطمئنه ونخبره أن هذا الاضطراب شائع وأننا سوف نفسر له سبب ظهور تلك الاعراض وكيفية علاجها.

٢) نعطي الشخص تفسيراً للوضع الئي هو فيه (التثقيف النفسي له ولاسرته)

- عندما نفسر للشخص طبيعة مشكلته، سوف يعي أسباب الأعراض التي يحسّها وتتبدّد شكوكه، نفسر.بكلمات عامة أن كل شخص يشعر من وقت إلى آخر بأعراض ناتجة عن مشكلات نفسية او جسدية.
- في حالات مابعد الولادة; تشعر نساء كثيرات بالألم والانزعاج من حين إلى آخر... وتشعر بالتعب ومواجهة مشاكل في النوم وقد تشعر بعض النساء أيضا بالحزن، ويفقدن الاهتمام بالطفل. فيمكن أن نعطي تفسيراً أبعد لطبيعة الأعراض إذا عرفنا كيف بدأتْ. مثلاً، نستطيع أن نقول له **غالباً مايشكو الشخص من مشكلات في النوم، وأوجاع، ومشاعر قلق، عندما يعاني حالة من الضغط النفسي او الارهاق والتعب.**
- المراة التي توفّي زوجها وترك أولادها المنزل، فاصبحت مكتئبة. فنفسر لها انه غالباً ما يواجه الأشخاص في مجتمعاتنا المحلية هذه المشكلة. وكلّ المشكلات التي وصفتِهاناتجة عن هذا الاضطراب العاطفيّ. وهذا لا يعني أنك كسولة أومريضة نفسيّاً،
- في حالات اخرى مثلا إنّ الأعراض التي تحسّ بها، من ضيق التنفس، والدوار، وتسارع خفقان القلب، والخوف، ناتجة عن **نوبات القلق**. وهذه مشكلات شائعة لا تدلّ على مرض خطير. تأتي هذه الأعراض لأنك متوتّر أو قلق لسببٍ ما، وعندما تكون متوتّراً، تتنفّس أسرع من العادة وسرعة التنفس تُحدث تغييرات في جسمك، الأمر الذي يُسرّع نبضات القلب، ويدفعك إلى الخوف من أنّ أمراً رهيباً قد يحصل. ولو أنّكَ سيطرتَ على تنفّسك، لتمكنت من أن توقف النوبة على الفور. وربّما أنت تعاني نوبات القلق هذه بسبب الصدمة الناتجة عن الحادث الذي قُتل فيه صديقك. قد يحدث هذا مع أيّ شخص وهو لا يدلّ على أنّك سوف تصاب بالجنون.
- في حالات اخرى مثلا إنّ مشكلات النوم، والغثيان في الصباح، وأوجاع المعدة، كلّها شكاوى متعلّقة بكثرة الشرب. فالكحول تسبّب الإدمان بشدّة، ولهذا ترغب في الشرب طوال الوقت، وتشعر بالغثيان عندما تستيقظ. أي أنّ انقطاعك عن الشرب هو الذي يسبّب شعورك بالغثيان، ولهذا تشعر بأنّك أفضل حالاً عندما تشرب في الصباح. وبالتالي، أنت تشعر بالاكتئاب والحزن لأنّك فقدت السيطرة على الشرب ولأنك تحسّ بأنّك مريض فإذا توقّفت عن الشرب، فلابدّ من ان تختفي هذه المشكلات وتشعر بتحسن.
- من المهم أيضاً أن نسأل الشخص عن السبب الذي نتج عنه المرض برأيه، وعن العلاج الذي يظنّ أنّه سيفيده. فإذا فهمنا وجهة نظره، سيساعدنا ذلك كثيراً في التخطيط للعلاج.
- فإذا أخذنا مثلاً شخصاً يظنّ أنّ الأرواح الشريرة هي سبب مشكلته، يمكن أن نقترح عليه أن يستشير رجل دين ليعطيه الإرشاد الروحيّ، وأن نُفهمه أنّ الضغط هو سببٌ آخر لأعراضه.
- علينا الا نستخفّ بوجهة نظر الشخص، ولو بدت لنا غير علميّة، لأنّ النتيجة ستكون أفضل حتماً إذا استمعنا إلى رأي الشخص في المشكلة وتفهّمناه.

٣) اعطاء نصائح لأعراض معيّنة قد يعاني منها المريض:

- يكون الإرشاد النفسي أكثر فعالية إذا كان متناسباً مع الأعراض التي يشكو منها الشخص. وفي ما يلي أمثلة على كيفيّة التعامل مع أعراض معيّنة:
- **نوبات الذعر:** تنتج عن نوبات الذعر اعراض كسرعة التنفس. وتمارين التنفس هي طريقة مفيدة جدّاً للسيطرة على هذه النوبات.
- **الرهاب:** الرهاب هو عندما يشعر الشخص بالخوف الشديد، بل بنوبات من الذعر، في حالات وظروف معيّنة، ويبدأ بتجنّب هذه الحالات والظروف. والطريقة الفضلى للتعامل مع الرهاب، هي بمواجهة الحالة المسببة للذعر بدلاً من الهروب منها.

- **التعب والإرهاق:** غالباً ما يشعر الأشخاص المحبطون بالتعب والوهن ونتيجةً لذلك، ينقطعون عن نشاطاتهم ويزداد شعورهم بالضعف والإحباط. ولكسر هذه الحلقة المفرغة يمكن تشجيع الشخص المحبط تدريجيّاً على زيادة الفعاليات الاجتماعية والنشاطات الجسديّة.
- **مشكلات النوم:** هذه المشكلات شائعة جدّاً. ويمكن أن نساعد معظم الأشخاص على استعادة نظام النوم عندهم، إذا أعطيناهم نصائح بسيطة حول عادات النوم السليمة, واهمية اجراء تمارين رياضية او القراءة وغيرها.
- **القلق بشأن الصحة الجسدية:** هذه أيضاً حالة شائعة، ولا سيّما عندما يشكو الشخص من أعراض جسدية كثيرة، من أوجاع وآلام. فبيان ان الشخص لايشكو من شيء جسدي والدليل ات كافة فحصواته سليمة وان معظم العلاجات لم تاتي بنتيجة فان حالته تتطلب علاجا نفسيا منتظما فان سوف يقتنع.
- **حدّة الطبع وسهولة الانزعاج:** يشكو بعض الأشخاص من أنّه يواجه صعوبةً في السيطرة على رد فعله. يمكننا ان نستعين ببعض الوسائل لمساعدتهم على التحكّم بغضبهم. كالاسترخاء, الابتعاد, التنفس البطيء وغيرها.

٤) تعلم تمارين الاسترخاء والتخيل والتنفس العميق:

لقد أصبح الاسترخاء ضرورة من ضروريات الحياة, لابد من تعلمه لمواجهة ضغوط الحياة المتزايدة والتغلب عليها. فعادةً عندما يسيطر التوتر النفسي على الشخص وعندئذ لا يستطيع أن يفكر بشكل سليم وتصبح ردود أفعاله مبالغ فيها أو غير طبيعية ولهذا يمكن أن تنعكس بشكل سلبي على الصحة الجسمية والنفسية معًا.

ويؤدى التعرض المتزايد للتوتر اليومي إلى زيادة إفراز بعض الهرمونات التي ينجم عنها الارتفاع في الضغط الدموي والإصابة بنقص الدورة الدموية للأعضاء الحيوية في الجسم والقلب والمخ وحدوث الجلطة، إضافة إلى ذلك يمكن أن يصاب الشخص ب:

- الاضطرابات الهضمية، أمراض القولون والمعدة.
- الاضطرابات النفسية المتعلقة بالنوم والاكتئاب.
- فقدان الرغبة بالعمل، وبالحياة أيضًا.

- وبالرغم من أننا لا نستطيع أن نتجنب الأحداث التي تحدد اتجاه حياتنا، ولكننا نستطيع إزالة التوتر والتغلب عليه بالاسترخاء الذي يسمح بتعديل ردود الفعل إزاء العوامل الخارجية، وبالتخلص بشكل تدريجي من العوامل المؤهلة لحدوث التوتر. وتستعمل معظمُ وسائل الاسترخاء نوعاً من تمارين التنفّس. ولهذه التمارين قيمة كبرى في مساعدة الأشخاص على تخطي مشكلاتهم العاطفيّة وهو علاج يمكن استخدامه للمريض او غير المريض. لكن لا تنفع تمارين الاسترخاء في حالات الذهان والوسواس القهري.
- يمكن القيام بهذا التمرين في أيّ وقت من النهار، وعلى الشخص أنّ يُكرّس له عشر دقائق في اليوم على الأقلّ. ومن الأفضل أن يقوم به في غرفة هادئة فلا يزعجه أحد.
- تمرين التنفس العميق يوفر كمية الاوكسجين المناسبة التي يحتاجها الجسم وإخراج اكبر قدر من ثاني أوكسيد الكربون، وينقل العقل والجسم إلى حالة استرخاء ويحسن من الدورة الدموية في منطقة البطن. حيث يمكن من خلال طريقة التنفس لإنسان متوتر أن ندرك مدى توتره أو كآبته أو قلقه. وهذا يعنى أن الإنسان الذي يعانى من توتر أو قلق أو اكتئاب لن يحصل على كمية الأوكسجين الضرورية التي يحتاجها الجسم، وذلك بسبب طريقة تنفسه التي قد تكون سريعة وتمنع حصول الجسم على الكمية المطلوبة من الأوكسجين وإخراج كمية ثاني أوكسيد الكربون.

وفي ما يلي الخطوات التي ينبغي اتباعه في تمرين التنفس العميق:

- يبدأ التمرين بالاستلقاء أو القعود بوضعيّة مريحة. القدمين متباعدين بعض الشئ, ليس ثمّة وضعيّة معيّنة، بل إن أيّ وضعيّة يجدها الشخص مريحة تُعتبر صحيحة.
- اغلاق العينين, ، وتخيل عالم آخر خيالي جميل أو تختآر مكان تحبه، وذلك للتقليل من المؤثرات الخارجية, بعد نحو عشر ثوان، عليه أن يبدأ التركيز على الشهيق والزفير.
- عليه أن يركّز على التنفس ببطء، وبشكل منتظم، ومتتال، عبر الأنف, وان يضع احدى كفيه على الصدر و الكف الأخرى على البطن وان يلاحظ ارتفاع هذه الكف اثناء الشهيق الى الأعلى قليلاً.. قليلاً، وليس كثيرًا (أي لا تتعمد ذلك بل اعمله بشكل طبيعي).

- إذا سألنا عن درجة البطء في التنفس، فعلينا القول له أن يعدّ ببطء حتى ثلاثة في أثناء الشهيق، ويحبس النفس بالعد حتى الثلاثة, ثم يعدّ حتى ثلاثة في أخراج الزفير من الفم، ثم يتوقف عن التنفس بالعد حتى الثلاثة، إلى أن يعود إلى الشهيق من جديد.
- تكرر هذه العملية (الاستنشاق من الأنف وحبس الهواء، ثم زفره من الفم ٣ مرات) وبعد المرة الثالثة نأخذ نفسا عميقًا من الأنف ولا نحبسه ثم نخرجه من الأنف لكرتين متتاليتين.
- نظهر للشخص كيف ينبغي أن يتنفّس نفساً عميقاً، وبشكل متتال, أي أن التمرين يتكون من وحدتين أساسيتين هي حبس الهواء 3 مرات، ثم 2 دون حبس، ثم نعيد المرات الثلاثة مع الحبس، ثم المرتين دون حبس إلى أن يمر علينا من الوقت خمس دقائق.
- نشرح له أنّه إذا تمرّن يوميّاً، فسوف يشعر بفوائد الاسترخاء في غضون أسبوعين. وإذا طبّق التمرين بطريقة جيّدة، فسيتمكن حتى من أن يقوم به في أوضاع مختلفة، في أثناء جلوسه في الباص مثلاً.

٥) تخفيف الضغوط النفسية و مواجهتها:

الضغوط النفسية: يمرّ الانسان في حياته بالكثير من الضغوط والأزمات والشدائد والمشقات التي من شأنها أن تؤثر سلباً في حياته فسيولوجياً ونفسيا إذا لم يتهيأ ويتعلم الطرق والأساليب لتقبلها والتعامل البنّاء معها، وليس هناك مناص ومفر من مرور الإنسان في مثل هذه الضغوط، ومن غير الممكن منع حصولها جميعا. أما استجابات الأفراد لهذه الضغوط فإنها متفاوته, فبعض الأفراد قد يصاب بالحزن والتوتر وبشعور سلبي عند مواجهته ضغوط نفسية شديدة وبعض الأخر يؤمن بأنّ تعرّضه للضغوط من فترة إلى أخرى يجعله أكثر قدرة وكفاءة على القيام بالمهام وإنجازها وأكثر جرأة على خوض التحديات والنجاح فيها، وبالتالي حصول الفرد على الشعور الإيجابي الذي يتبع هذا النجاح.

تعرف الضغوط النفسيّة: على انها الاستجابات التي تشمل حالة اللاشعور التي يمرّ بها الفرد، حيث تتطلب منه استنزاف واستنفار كافة أشكال الطاقة الطبيعيّة في جسم الإنسان لتهيئته لمواجهة الظروف الصعبة. أو أنها مجموعة من المثيرات التي تصيب الفرد، ومحصّلة الاستجابات المترتّبة عليها، بالإضافة إلى مستوى الخطر الذي يقوم الفرد بوضعه وتقديره للمثير، والأساليب والاستراتيجيات التي تساعد على عملية التكيف مع كافة أشكال الضغوط، والطرق الدفاعية النفسية التي تستدعي استخدامها في الظروف المختلفة.

تختلف استجابات الافراد للضغوط النفسية اعتمادا على الاتي:

- **شدة الضغوط النفسية وفترة التعرض اليها**
- **عمر الفرد وجنسه**
- **طبيعة شخصية الفرد وقدرته على التأقلم**
- **افتقاره الى دعم اسري ومجتمعي**
- **وجود تاريخ لاضطراب نفسي سابق**

تعتمد انفعالات الافراد على نوع الاحداث او التحديات التي يواجهونها:

- انفعالات تأخذ شكل القلق النفسي أذا كان الحادث ذا محتوى مخيف أو فيه تهديد أو خطورة
- انفعالات تأخذ شكل الإكتئاب إذا كان الحادث هو فقدان شخص أو شيء عزيز جداً
- انفعالات تأخذ شكل القلق والإكتئاب معاً أذا إجتمع في الحادث التهديد والفقدان.

ويظهر تاثير الضغوط النفسيّة عند تفاعل العوامل الثلاثة ادناه مع بعضها لتُنتج بدورها حالات القلق والاكتئاب والتوتر التي تسيطر على ذات الفرد ونفسيّته.

١. **البيئة الخارجيّة التي يعيش فيها الفرد،**
٢. **المشاعر والأحاسيس السلبيّة التي تسيطر على الفرد،**
٣. **مجموعة الاستجابات الجسميّة الفسيولوجيّة الصادرة عنه،**

مصادر الضغوط النفسية نوعان:

- **داخليّة ذاتيّة المنشأ** وهي عبارة عن الأفكار والاستجابات التي تنبع من الأفكار والمعتقدات الخاطئة وغير الواقعيّة، ومدى قدرة الفرد على تحمّل ومواجهة الظروف والضغوط المختلفة،
- **أو بيئيّة خارجيّة المنشأ** وهي العوامل الاجتماعيّة، والصراع بين القيم والعادات والمعتقدات وبين الواقع، بالإضافة إلى الأحداث والتغيّرات المأساويّة والعنيفة والمؤلمة والصدمات التي من الممكن أن يتعرّض لها الفرد؛ كالتهديد وفقدان أحد الأشخاص المقربين، أو خسارة مبلغ كبير من المال وغيرها.

قسم العلماء الضغوط النفسيّة إلى أربعة أقسام وهي كالآتي:

- **العوامل البيئيّة:** كالتقلّبات المناخية، وحالات التلوّث والتغيرات المفاجئة في حالة الطقس.
- **العوامل الفسيولوجيّة الجسمية:** وهي العوامل التي تخصّ البنية الجسمية للفرد مثل: المرور بالمراحل العمريّة والنمائيّة المختلفة، والأمراض والحوادث والإصابات المزمنة، واضطراب النوم، وحالات القلق، وآلام المعدة التي تنتج عن تذبذب الاستقرار الاجتماعيّ والبيئيّ والخوف من حدوث التغيرات الطارئة.
- **العوامل الاجتماعية:** كالمواعيد والمقابلات المصيريّة والمهنيّة، والتعرض للمشكلات المالية، والخوف والتوتر عند الإقدام على إلقاء محاضرة أو ندوة عامة أمام الجمهور، وفقدان أحد الأقارب أو الأصدقاء المقرّبين، بالإضافة إلى محاولة تلبية المتطلبات الزمنية لإجراء وإنجاز المهام المختلفة.
- **العامل الداخلي:** أي البنية النفسيّة للفرد وطرق تفاعلة واستجاباته للمثيرات المختلفة.

أعراض الضغوط النفسية:

تظهر على الفرد الذي يقع تحت وطأة الضغوط النفسيّة الكثير من الأعراض، وهي كالآتي:

- **الأعراض الجسميّة:** وهي ردّات الفعل الفسيولوجيّة التي يستجيب لها الجسم للمثيرات المختلفة التي من شأنها أن تولّد حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار، ومنها ارتفاع عدد نبضات القلب وزيادة قوة خفقانه، وتشنّج العضلات المختلفة، بالإضافة إلى آلام المعدة والتعرّق الشديد والمستمر وسرعة النفس وضيقه.
- **الأعراض الادراكية:** الضعف العام في التركيز ومواجهة الصعوبات في أداء العمليّات الذهنيّة.
- **الأعراض العاطفيّة والانفعاليّة:** كسرعة الاستثارة والغضب والانفعال والقلق والتوتر، وقد تظهر بعض الانفعالات الباردة نسبيّاً التي تظهر في الحزن والإحباط والاكتئاب والانسحاب.
- **الأعراض السلوكية:** والتي تظهر عند تعرض الفرد للضغوط كردة فعل للطاقة السلبية الكامنة ومحاولة تفريغها بالحركات الجسمية النمطيّة؛ كهزّ الركبة، وقضم الأظاهر، بالإضافة إلى التدخين وغيرها من العلامات، وإلقاء الأخطاء الشخصيّة على الآخرين.

طُرق التعامل مع الضغوط النفسيّة وأساليب مُواجَهتها:

- إنّ الاستجابة السلبيّة للضغوط النفسيّة التي قد يُبديها بعض الأفراد تُشكّل خطراً كبيراً على توازُن الفَرد واستقراره النفسيّ؛ فعدم قُدرة الفرد على التكيُّف السليم مع مُجريات حياته الصعبة والقاسية، ستؤدّي به إلى عَجزٍ في مُمارَسة أنشطته اليوميّة الروتينيّة، وانخِفاض مستوى الدافعيّة للعمل، والإنجاز،
- أمّا مفهوم مُواجَهة الضغوط النفسيّة، فمن الممكن تعريفه بأنّه مجموعةٌ من الوسائل والطُّرق التي تُسهِّل عمليّة التكيُّف مع المواقف، والمُثيرات الخارجيّة البيئيّة، كما أنّها عبارةٌ عن عمليّة تعلُّم بعض الأنماط السلوكية، التي يُبذَل الجُهد في سبيل اكتسابِها؛ بحيث تستهدفُ حلَّ المشكلة؛ وبالتالي إمكانيّة السيطرة عليها، وضَبطها، والتحكُّم بها، والتقليل والحدِّ من آثارها الجانبيّة السلبيّة قَدْرَ الإمكان،

ومن أهمّ طُرق مُواجَهة الضغوط النفسيّة ما يأتي:

١) **تنمية الوعي الذاتيّ**: ويتمّ ذلك بتوصُّل الفرد إلى حالة من إمكانيّة سيطرته على مشاعره وانفعالاته، وضَبطِها، من خلال وَعيِه بحقوقه، وواجباته، ومن أهمّ النقاط التي تُعالج هذا الموضوع هي:

٢) **تنمية الاهتمامات الشخصيّة** خارج نطاق العمل، كالاشتراك بالأنشطة، والفعاليّات البديلة، التي تأخذُ الفَرد بعيداً عن أجواء العمل، والتي غالباً ما تتَّسم بالضغط والجدِّية، وبذلك فإنّه من المُفيد أن يجعلَ الفَرد لنفسه بيئة إيجابيّة بديلة.

٣) **التمارين البدنيّة**؛ حيث تُعتبَر التمارين الرياضيّة، والأنشطة البدنيّة من الوسائل الفعّالة؛ لمساعدة البيئة الجسميّة على التعامُل مع الضغوط المُختلِفة والتكيُّف معها.

٤) **التقييم المعرفيّ**؛ حيث إنّ من مُسبِّبات الضغوط النفسيّة عمليّة التقييم المعرفيّ الذي يقوم به الفَرد في تحليل مُجرَيات الأحداث والوقائع التي يمرُّ بها بشكل سلبيّ، وتفسيرها بطريقة غير توافُقيّة؛ وللتخلُّص من هذه الضغوط، يعمل المرشد بتمكين الفرد في أن يعيدَ برمجته لعمليّة تفسيره، وتقييمه للضغوط الخارجيّة إيجابيّاً، وتحفيزيّاً.

استراتيجيّات مُواجَهة الضغوط النفسيّة:

- **الاستراتيجيّات الفسيولوجيّة التي تتركَّزُ حول المشكلة:** وتُستعمَل هذه الطُّرق غالباً إذا كان مصدر الضغوط فسيولوجيّاً، كإصابة الفَرد بمرض مُزمِن؛ حيث تعملُ على إضافة بعض التعديلات على أسلوب حياة الفَرد، وطريقة تفاعُله وتكيُّفه مع مَرَضه.
- **الاستراتيجيّات المعرفيّة التي تدور حول المشكلة؛** حيث تُستخدَم في تعديل طريقة إدراك الإنسان للمواقف التي تُشعِرُ الفَرد بأنّه واقعٌ تحت تأثير الضغوط، وطريقته في تحليل هذه الضغوط، والأساس الذي سبَّب المُشكلة التي أدَّت إليها، ومن أساليبها: التغلُّب على أنماط التفكير غير السليمة، وغير المنطقيّة، بالإضافة إلى توظيف الفرضيّات، واختيارها، واختبارها في عمليّة حل المُشكلات.
- **الاستراتيجيّات السلوكيّة التي تتركَّز حول المشكلة:** وهي بعض الطُّرق والأساليب التي تُساعدُ الفَرد في وَضعِ بعض التعديلات على طبيعة المواقف الضاغطة، كامتلاك مهارة إدارة الوقت، والانفِتاح على اكتساب المهارات والخبرات الجديدة، بالإضافة إلى السَّعي المُتواصِل؛ لتوحيد الذات.
- **الاستراتيجيّات السلوكيّة التي تدور حول الانفعال:** وتهدفُ إلى تعلُّم الآليّة السليمة؛ للاستجابة لهذه الضغوط، أي تعلُّم اكتساب أنماط جديدة، كاستخدام المرح، واللعب، والدعابة؛ لتخفيف حدّة الاستجابة للمواقف الصعبة، والمُسبِّبة للضغوط النفسيّة المُختلِفة.
- **الاستراتيجيّات الفسيولوجيّة التي تدور حول آليّة الانفِعال؛** حيث تهدفُ إلى وصول الفَرد إلى إمكانيّة التعامُل السليم مع الأعراض الفسيولوجيّة الناجمة عن الضغوطات المُختلِفة، كالتدريب على الاسترخاء والتخيل وعملية التنفس العميق، وتعديل بعض الأساليب الحياتيّة المعيشيّة؛ لتصبح أكثر إيجابيّة وفائدة.

الخطوات العملية لادارة الضغوط النفسية:

- **الأسبوع الاول: تسجيل الأحداث**
- **الأسبوع الثاني: تحديد الضغوطات ووضع خطة**
- **الأسبوع الثالث: خلق عادات جديدة**
- **مراجعة وتقييم**

الأسبوع الاول: تسجيل الأحداث

المرحلة الأولى هو جمع المعلومات لمدة سبعة أيام، وملء سجل التوتر في كل مرة يشعر الشخص بالتوتر أو القلق. وكتابة دفتر يوميات كل ليلة، يلخصفيها الفرد اليوم والمشاعر المرتبطة بالضغوطات.

سجل التوتر يتضمن المعلومات التالية
ماذا حدث؟
متى حدث ذلك؟
اين حدث ذلك؟
كم كان مستوى التوتر لديك لايوجد توتر (١), توتر متوسط (٥), توتر شديد (١٠)
بماذا احسست؟
لماذا اصابك هذا الحدث بالتوتر؟
ماذا فعلت حيال ذلك ؟
ما تود القيام به بشكل مختلف في المرة القادمة؟

الأسبوع الثاني: تحديد الضغوطات ووضع خطة لمواجهتها

كتابة الأحداث التي تتسبب في أعلى مستويات التوتر وتحديد الضغوطات الرئيسية ووضع خطة لكل منها من خلال:

- اختيار الحل الانسب في التعامل مع هذا الوضع؟ (تغيير، وتجنب، وقبول)
- كيف يمكن تغيير نمط الحياة (النظام الغذائي، والنوم، وممارسة، الروتينية، وتنظيم) للمساعدة في تخفيف التوتر؟
- ماهي تقنيات الاسترخاء التي يمكن أن تساعد على مواجهة هذه الضغوط؟
- ما هي الموارد (مثل أنظمة الدعم والمساعدة الخارجية) يمكن أن تساعد في الحد من هذه الضغوطات؟

الأسبوع الثالث: خلق عادات جديدة

- اختيار جزء واحد أو اثنين من خطة إدارة التوتر ودمجها في حياة الفرد. وتجربة كل جزء لمدة أسبوع أو اثنين.
- مواصلة إدماج طرق وعادات جديدة في نمط حياة الفرد.

مراجعة وتقييم

- ما كان مستوى التوتر لدي آخر مرة راجعت خطتي؟
- ما هو مستوى التوتر لدي الآن؟
- ما الذي تغير؟
- ماهي الضغوطات التي أُضيفت إلى حياتي؟
- ماهي الضغوطات التي أُزيلت من حياتي؟
- كيف أُغير خطتي؟
- ما هي النصائح التي نجحت معي؟ ما هي التقنيات التي لم تنجح؟ كيف أُغير خطتي؟
- ما هي خطتي للأسبوع المقبل؟
- متى سأستعرض خطتي مرة أخرى؟

٦) تعلم مهارة ادارة المشكلات:

- هي طريقة تعلّم الأشخاص كيف أنّ المشكلات في حياتهم تشعرهم بالقلق والاكتئاب، وكيف تمنعهم هذه المشاعر من حلّ مشكلاتهم. وليس الهدف هنا أن تحلّ مشكلةً معيّنة، بل أن تعلّم الشخص هذه المهارات لكي يتمكن من ادارة مشكلاته بنفسه وبشكل فعّال.
- مثال:

- العلاقات غير السعيدة (شائعة).
- نتيجةً لهذه المشكلة يصبح الشخص حزيناً.
- هذا قد يؤدّي إلى الارهاق وقلّة التركيز.
- الأمر الذي سوف يزيد العلاقة سوءاً.

❑ مثال اخر:

- يفتقر الشخص إلى المال الكافي ليؤمّن حاجاته اليوميّة (شائعة).
- وهذا قد يدفعه إلى اللجوء إلى الكحول.
- فيصبح الشخص أشدّ فقراً لأنه ينفق المال الثمين على الكحول.
- يسوء عمله فيخسر وظيفته او مهنته.
- هذا سيشعره بالحزن واليأس.
- يضاعف شرب الكحول وتزداد مشكلاته الماديّة.

أنواع المشكلات التي سنواجهها

❑ مشكلات في العلاقة مع شريك الحياة، مثل سوء التواصل، وكثرة التجادل، والعنف في العائلة، والحياة الجنسيّة غير المُرضية.
❑ مشكلات في العلاقة مع الأشخاص الآخرين، مثل أهل الزوج أوالزوجة، أو الأولاد، أو الأقرباء، أو الأصدقاء.
❑ مشكلات في العمل، مثل البطالة أو كثرة العمل.
❑ مشكلات ماديّة، مثل قلة المال، والديون.
❑ مشكلات في المسكن، لايوجد سكن او العيش في مكان غير مرتاح به.
❑ العزلة الاجتماعيّة، مثل أن يكون الشخص وحيداً في مكان جديد أو ألا يكون له أصدقاء.
❑ مشكلات صحيّة جسدية، خصوصاً إذا كانت مؤلمة وطويلة الأمد.
❑ مشكلات جنسيّة، مثل فقدان الرغبة الجنسيّة.
❑ الحداد أو فقدان شخص عزيز.
❑ مشكلات قانونيّة.

خطوات ادارة المشكلات

١. ندّون المشكلات

اي نضع قائمة بالمشكلات التي يعاني منها الشخص ونحدد المشكلات القابلة للحلّ(التي يمكن التأثير فيها أو تغييرها)وغير القابلة للحلّ(التي لا يمكن التأثير فيها أو تغييرها)

❑ نسأل الشخص عن المشكلات التي تواجهه في حياته.
❑ غالباً ما يكون تحديد المشكلات صعباً،
❑ غالبا المشكلات الحساسة هي الأهم والأكثر إيلاماً. لكن من الأفضل أن نبدأ بموضوع (غير حساس) مثل العمل، قبل التطرّق إلى المواضيع الحساسة مثل الجنس.
❑ طريقة مفيدة لطرح الأسئلة الحساسة:

- أحياناً عندما يشعر الناس بالحزن او التوتر فانهم يفقدون الرغبة الجنسيّة بعض الشيء، فهل حصل هذا معك.
- غالبا الأشخاص القلقين يشربون الكحول للتخفيف عن قلقهم, فهل تتناول احيانا بعض المشروبات.

- هذه الطريقة في التطرق إلى الموضوع الشخصيّ (الحساس) تثبت للمريض « أننا لن نتفاجأ إذا قال نعم »

❑ نحدّد نقاط القوة عنده، فنعطيه مثلاً أمثلة عن حالات سابقة تُصوّر قدرته على التكيّف. (مشاكل سابقة استطاع تجاوزها)

❑ نحدّد المصادر الأساسيّة للدعم الاجتماعي، لكي نساعده على أن يدرك من هم الأشخاص الذين يهتمون لأمره.

٢. اختر أسهل مشكلة (قابلة للحلّ) للبدء بها وعرفها باكبر قدر ممكن من المعلومات

❑ نضع لائحة مع الشخص بكل مشكلاته، ونحدّد المشكلات التي تشغله أكثر من سواها.

❑ نختار معه اسهل مشكلة وقابلة للحل على المدى القريب.

❑ نحدّد مع الشخص المشكلة التي يرغب في معالجتها.

❑ ليس صحيحا أن نبدأ بالمشكلة التي تتطلب حلول طويلة الأمد.

❑ من المجدي أن نبدأ بالمشكلات التي لم يمض عليها وقت طويل، مثل التكيّف في العمل أو الشعور بالعزلة الاجتماعيّة.

❑ تذكّر أنّ هدف العلاج هو أن نعلّم الشخص مهارات حلّ مشكلاته، لا أن نجد حلول لحلّ كلّ مشكلاته.

❑ نحتاج إلى مزيد من الاسئلة. ولابد من الغور في أعماق المشكلة وتفاصيلها.

❑ نجزء المشكلة الى أجزاء عديدة وتعامل مع كل جزء على حدة.

٣. (عصف ذهني) التفكير في كل الحلول الممكنة لحل المشكلة او التاثير عليها واختر افضل حل

لتحديد الحلول، ينبغي اتباع الخطوات الآتية بالشراكة مع الشخص:

❑ نشجّع الشخص ونفكر معه على أن يبتكر حلول مختلفة لمشكلاته، فبهذه الطريقة نزيد من ثقته بنفسه. فإذا قال مثلاً إنّ الوحدة هي مشكلة أساسيّة بالنسبة إليه، ينبغي ألا نقول (أظن أنّ بإمكانك تخطّي هذا الأمر نهائيّاً إذا قمت بزيارة بعض الأصدقاء) الافضل ان نقول الآن وقد حدّدنا مشكلةً تودّ معالجتها، كيف تريد أن تبدأ بحلّها.

❑ اختر افضل حل: فان توافرت عدة خيارات، نركّز على الخيارات الأكثر عمليّة بالنظر إلى الحالة الاجتماعية للشخص.

❑ نحدّد بعض الأهداف المعيّنة التي يمكن أن يحقّقها الشخص قبل موعد المعاينة التالية.

❑ نفكر بما يمكن للعميل أن يقوم به بنفسه.ونفكر أيضاً بالأشخاص الذين يمكن أن يساعدوه. نحدّد نقاط القوة عنده، فنعطيه مثلاً أمثلة عن حالات سابقة تُصوّر قدرته على التكيّف. (مشاكل سابقة استطاع تجاوزها), ونحدّد من هم الأشخاص الذين يهتمون لأمره وماهي المصادر الأساسيّة للدعم الاجتماعي المتوفر له.

٤. وضع خطة عمل بمشاركة العميل

❑ اختر - من قائمة الحلول الممكنة – أكثر الحلول المجدية في التأثير على المشكلة.

❑ نطوير خطة عمل مفصلة عن كيفة تنفيذ العميل للحلول ومتى.

❑ نحدّد بعض الأهداف المعيّنة التي يمكن أن يحقّقها الشخص قبل موعد المعاينة التالية.

❑ ساعده كي يختار اليوم والوقت لتنفيذ ذلك.

❑ ساعده ليختار الحلول التي سيجربها في البداية

- ناقش الموارد التي قد يحتاجها لتنفيذ الخطة (مثال: يملك شخص وسائل مالية ، النقل، شخص آخر، ، أو موارد أخرى وغير ذلك).
- اقترح أدوات مساعدة لتذكير العميل بتنفيذ الخطة (ملاحظات، رزنامة، خطة أنشطة تتزامن مع وجبات الطعام أو أحداث روتينية أخرى).

٥. المتابعة والتقييم (مراجعة مدى نجاح خطة العمل والخطوات اللاحقة)

- **مراجعة الجلسة السابقة:** نراجع باختصار كل ما ناقشناه مع الشخص في خلال اللقاء. ونراجع خصوصاً وماتحقق من الخطة التي وضعت.
- **الأهداف الأساسيّة من الجلسات اللاحقة هي:**
  - تقييم نجاح الشخص في إتمام المهمات
  - في حال التقدّم، تطبيق حلول جديدة للمشكلة نفسها، أو البحث عن حلول لمشكلة جديدة.
  - في حال عدم التقدّم، تحديد الأمور التي أفشلت الحلّ، ووضع أهداف جديدة.

عند تقييم التقدّم، يجب ان نكون دقيقين فلا جدوى من أن نسأل كيف جرت الأمور معك؟ وأن نكتفي بأن يحرّك المريض كتفيه ويعطينا إجابة غامضة مثل لابأس بل نسأل عن تفاصيل ما قام به الشخص بالتحديد، كما يلي:

- ماذا فعل باتجاه تحقيق الهدف؟
- هل كان ذلك سهلاً أم صعباً؟
- كيف أثّر على مشاعره وعواطفه؟
- هل المهمة تمّت بشكل مُرض وتريد الانتقال إلى هدف اخر؟
- إذا لم تتمّ المهمّة، فما هي الصعوبات التي واجهتها؟
- ناقش مايمكن تنفيذه في الاسبوع القادم للاستمرار في التاثير على المشكلة.

٧) العلاج السلوكي المعرفي (مخصص للباحثين النفسين):

العلاج السلوكيّ المعرفيّ هو أحد أنواع العلاج النفسيّ، ويكون بشكل منظّم ولفترة زمنيّة محدّدة، يتمّ فيه عقد عدّة جلسات محدّدة مسبقاً، يقوم فيها المعالج النفسيّ بمساعدة المريض ليصبح أكثر وعياً للأفكار السلبيّة وغير الصحيحة، ومواجهة المواقف الصعبة بطريقة أكثر وضوحاً والاستجابة لها بشكل فعّال أكثر، ويمكن لغير المرضى أن يستفيدوا ايضا من العلاج السلوكيّ المعرفيّ، فالعلاج يساعد على مواجهة مواقف الحياة المجهدة بشكلٍ أفضل.

يقوم هذا العلاج على النموذج الإدراكيّ، حيث يعتمد على طريقة استقبال الفرد لحدث معيّن بشكل مرتبط بردّ فعله أكثر من التركيز على الحدث نفسه، والجزء المهم في هذا العلاج هو مساعدة الشخص على تغيير أفكاره غير المفيدة، وتغيير سلوكه بشكل ينعكس إيجاباً على مزاجه وعمله.

يُعدّ العلاج السلوكيّ المعرفيّ طريقةً للحديث عن شعور الإنسان حيال نفسه، وحيال الآخرين وحيال العالم من حوله، إضافةً إلى الحديث عن الأشياء التي تؤثّر في مشاعر وأفكار الإنسان، ومن الجدير بالذّكر أنّ هذا العلاج يركّز على المشاكل والصعوبات التي يواجهها الشخص في الوقت الراهن وفي المكان الراهن؛ أي أنّه علاج يركّز على الحاضر بدلاً من التركيز على الأسباب الماضية التي ربما تكون سبباً في ظهور هذه الأعراض على الشخص، وبالتالي فهو علاج لتحسين حالة الشخص النفسية في الوقت الحاضر.

خطوات العلاج السلوكيّ المعرفيّ وتشمل الخطوات الآتية:

١) **تحديد المواقف التي يعاني المريض من مشاكل خلالها**: من الممكن أن تكون المشكلة هي حالة طبيّة يعاني منها المريض، أو طلاق، أو حزن، أو غضب، أو أن تكون المشكلة هي الأعراض التي يعاني منها المريض جرّاء الإصابة بمرض نفسي، وفي هذه الخطوة يقوم المعالج النفسيّ مع المريض بتحديد المشاكل والأهداف التي على المريض التركيز عليها خلال المعالجة المعرفيّة السلوكيّة.

٢) **اكتساب المريض وعياً تجاه مشاعره وأفكاره ومعتقداته حول هذه المشاكل**: عندما يقوم الشخص بتحديد المشكلة التي يعاني منها، يساعد المعالج النفسيّ الشخص على مشاركة أفكاره الخاصّة تجاه المشكلة، وهذا يتضمن مراقبة الكلام الشخصيّ الذي يسرده المريض عن تجربة معينة، بالإضافة إلى مراقبة تفسيره للموقف ومعتقداته الخاصّة والشخصيّة عن نفسه وعن الآخرين وعن الأحداث، كما يمكن أن يقترح المعالج النفسيّ على المريض البدء بتسجيل الأفكار الخاصّة به على كرّاسة أو دفتر خاصّ.

٣) **تحديد الأفكار السلبيّة وغير الصحيحة:** حيث تساعد هذه الخطوة الشخص على تحديد طريقة التفكير والسلوك التي ربما قد تكون ساهمت في المشكلة، وهنا يحثّ المعالج النفسيّ الشخص على الانتباه إلى ردّات الفعل الجسديّة والعاطفيّة والسلوكيّة التي يتخذها في المواقف المختلفة التي قد يتعرّض لها.

٤) **إعادة تشكيل الأفكار الخاطئة السلبيّة:** يشجّع المعالج النفسيّ الشخص على سؤال نفسه عن الأساس الذي يبني عليه وجهة نظره؛ هل يبنيها على حقائق، أم يبنيها على تصوّرات غير صحيحة وغير دقيقة لما يجري، وتعدّ هذه الخطوة صعبةً في العلاج لدى المريض، فربما اعتاد المريض على التفكير منذ زمن طويل بطريقة ما حيال حياته ونفسه، ولكن مع التدريب والممارسة يصبح نمط السلوك والتفكير المفيد عادةً عند الشخص لا تتطلّب الكثير من الجهد.

استخدامات العلاج السلوكيّ المعرفيّ:

يتم استخدام العلاج السلوكيّ المعرفيّ لعلاج شريحة واسعة من الأمراض، ويتم تفضيل هذه الطريقة في العلاج لأنها طريقة منظّمة ويحتاج المريض خلالها إلى جلسات علاج أقل مقارنةً بباقي العلاجات النفسيّة، بالإضافة إلى أنّ هذه الطريقة في العلاج تساعد على تحديد ومعالجة تحدّيات بعينها، فعلى سبيل المثال يمكن أن يُستعمل العلاج السلوكيّ المعرفيّ في علاج التحدّيات العاطفية، ويمكن لهذا العلاج أن يساعد على علاج أعراض الأمراض العقليّة ومنع الانتكاسة في ظهور هذه الأعراض، كما يفيد هذا العلاج في بعض الحالات التي يكون فيها العلاج بالأدوية ليس خياراً علاجيّاً مناسباً، بالإضافة إلى كون العلاج السلوكيّ المعرفيّ يساعد المرضى على تخطّي إصابتهم بالأمراض الطبيّة الأخرى، وتعليمهم كيفية السيطرة على أعراض الأمراض المزمنة، ويساعد أيضاً في حالات الحزن والخسارة.

يمكن استخدام العلاج السلوكيّ المعرفيّ في علاج ما يلي:

- اضطرابات النوم, اضطرابات الأكل
- اضطرابات القلق, الرّهاب, اضطراب الوسواس القهري
- الاكتئاب.
- اضطراب ثنائيّ القطب
- الفصام
- الاضطرابات الجنسيّة.
- اضطرابات تعاطي المخدرات
- يمكن الاستفادة منه بشكل أكبر عند استخدامه مع العلاجات الأخرى، كالأدوية المضادة للاكتئاب.

مدة العلاج السلوكيّ المعرفيّ:

يعدّ العلاج السلوكيّ المعرفيّ علاجاً قصير المدى، ويتم مناقشة عدد الجلسات التي يحتاجها الشخص مع المعالج النفسيّ، لكن عادة ما يحتاج الشخص من عشر جلسات إلى عشرين جلسة، ويعتمد ذلك على عدّة عوامل منها:

- نوع الاضطراب أو المشكلة التّي يعاني منها الشخص،
- شدّة الأعراض ومدى التوتّر الذي يمرّ به الشخص، ،
- المدّة التي يعاني منها المريض من الأعراض أو من المشكلة،
- ما مدى التقدّم الذي يحرزه المريض في مدّة العلاج، إلى جانب
- ما مدى الدعم الذي يتلقّاه من أفراد عائلته والأشخاص الآخرين من حوله.

نصائح للاستفادة من جلسات العلاج السلوكيّ المعرفيّ:

أنّ نسبة الاستفادة من العلاج السلوكيّ المعرفيّ ليست متساويةً للجميع، ومن أجل تحقيق أكبر استفادة منه يمكن أن يتّبع الشخص النصائح الآتية:

- مشاركة المريض الفعّالة في العلاج وفي صنع القرارات مع المعالج النفسيّ.
- انفتاح المريض وصدقه، حيث إنّ نجاح العلاج يعتمد بشكل كبير على رغبة المريض في مشاركة أفكاره ومشاعره دون الشّعور بالحرج، وأن يكون المريض منفتحاً على تقبّل رؤى وطرق جديدة لصنع الأشياء.
- الالتزام بالخطّة العلاجيّة، فعدم الالتزام بها قد يؤدّي إلى عرقلة تقدّم العلاج.
- عدم توقّع نتائج فوريّة، فالعمل مع الأمور العاطفيّة مثلاً قد يكون مؤلماً للشخص، حتّى إن الشخص ربّما سيشعر بسوء أكبر خلال الجلسات العلاجيّة الأولى، وذلك بسبب بدء مواجهة الصراعات الماضية والحاضرة التي يعاني منها الشخص، وقد يحتاج الشخص لعدّة جلسات قبل أن يشعر بالتحسّن.
- القيام بالواجبات التي يوكلها المعالج النفسيّ للمريض بين الجلسات العلاجيّة، لأنه هذه الواجبات تساعد المريض على ممارسة ما تعلّمه خلال الجلسات.
- إذا لم يشعر المريض بأيّ تحسن بعد عدّة جلسات، لا بدّ من إخبار المعالج النفسيّ. بذلك، حيث يمكن اتخاذ قرار مشترك بين المريض والمعالج بإجراء بعض التغييرات أو تغيير الخطّة العلاجيّة.

التنشيط السلوكي كنموذج من نماذج العلاج المعرفي السلوكي:

يمكن تعريف التنشيط السلوكي بأنه عملية علاجية تركز على تنفيذ اجراءات وتقنيات (ممارسات) تهدف إلى زيادة نشاط المريض وفعاليته للحصول على التعزيز الداخلي والخارجي من البيئة المحيطة به لتنشيط الاتصال الاجتماعي وإنتاج تحسنات مماثلة في الأفكار، والمزاج، وجودة الحياة عموماً والتخلص من أعراض الاضطرابات النفسية. ويستند التنشيط السلوكي على النظرية القائلة بأنه كلما أصبح الأفراد مكتئبين، فإنهم يميلون إلى الانخراط في التجنب والعزلة، والذي يعمل على تفاقم الأعراض والحفاظ عليها. وان العمل مع هؤلاء الافراد بشكل تدريجي لتجنب العزلة وزيادة مشاركتهم في الأنشطة تساعدهم على تحسين المزاج. يستخدم التنشيط السلوكي جزء من تدبير الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب, اضطراب ما بعد الصدمة, والإدمان على المخدرات. فالاكتئاب يحتوي على مجموعة من الخصائص التي تعمل لديمومة الاكتئاب (مثل السلبية، والتعب، ومشاعر اليأس) والتي تقلل فرص التكيف واستعادة النشاط. فتدهور المزاج غالباً ما يعمل على ابطال المعاملة التكيفية، بما في ذلك الأحداث السارة التي تساعد على تخفيف وتجنب الاكتئاب وان إعادة إدخال أحداث سارة (أحد أشكال التنشيط السلوكي) يمكن أن تؤدي إلى تحسين المزاج العام. حيث تشير الأدلة التجريبية الأخيرة الى ان التدخلات السلوكية تعمل على:

- تحسن الأعراض المزاجية،
- تقلل أنماط التفكير السلبي وتعزز غير القدرة على التعامل (التكيف) مع المحيط.

يتكون التنشيط السلوكي من مجموعة من الأنشطة الممكنة بما في ذلك:

- الأنشطة والممارسات والهويات التي كانوا يتمتعون بها سابقا.
- التعامل الفعال لتخفيف أو تقليل ضغوطات الحياة أو التغلب على التجنب ؛ أمثلة: (الخروج لتناول العشاء، الاستحمام بانتظام, ترتيب اشياء فوضوية, تحسين العلاقات مع أفراد الأسرة, زيارة لاحد الاقارب)
- تعلم أنشطة ممتعة مهارات جديدة مثل تعليمهم على إجراءات النوم، وعادات الأكل ومهارات الاسترخاء والتخيل,
- العمل على استدامة تلك السلوكيات الجيدة.

خطوات التنشيط السلوكي:

- اختار بعض النشاطات التى باستطاعة المراجع القيام بها و التى من الممكن ان تجعله يشعر بالسرور و الراحه.
- اسئل المراجع: "ما هو النشاط الممتع لك، او ما هو النشاط الذى كان ممتعا بالنسبة لك فى الماضى"؟
- اذا لم يكن بمقدور المراجع ذكر اي نشاط محدد، قم بتزويده بقائمه من النشاطات المحتمله كمثال و اسئله هل هذه النشاطات ممتعه لك ام لا؟.
- قم بتعين تسلسل النشاطات من الاسهل الى الاصعب لتطبيقها
- اختار نشاطا واحدا لتعمل عليه.
- استقصى عن مدى صعوبه اداء هذا النشاط للمراجع و قم بكتابة خطة مع المريض لاداء هذا النشاط. الكثير من المرضى يستطيعون اداء النشاط، و لا يحتاجون ان يبدؤا من خلال خطوات صغيره جداً,
- اسئل اسئلة حول جدول زمنى لاداء النشاط لكى تجد الذين يحتاجون الى المساعده فى البدء بخطوات صغيره.
    - هل لديك طريقه ل-------؟
    - متى؟
    - "اى يوم فى الاسبوع ترى بانه من المناسب لك ل------؟ اى وقت فى اليوم ترى انك ستقوم به؟
    - اين؟
    - "اين تريد القيام به-----؟
- قم بتحديد ايه تحديات محتمله"هل هناك ايه شيء من المحتمل ان يجعل القيام بهذا النشاط صعبا فى [اليوم/الوقت المحدد]؟"
- اذا لم تكن هناك ايه تحديات تمنع المراجع من اداء النشاط، يجب على المراجع ان يقوم باداء النشاط كواجب بيتي فى هذا الاسبوع.
- اذا ذكر المراجع تحديات معينه، يجب تجزئه النشاط الى خطوات صغيره للتغلب على ايه تحديات تمنع المراجع من اداء الواجب و مساعده المراجع على اداء الواجب من خلال خطه مدروسه. (لا تحتاج الى تجزئه النشاط الى خطوات صغيره مع كل المراجعين).
- "دعنا نكتب قائمه من الخطوات الصغيره التى بامكانك القيام بها فى هذا الاسبوع لجعلك اقرب من اداء النشاط باكمله".
- اذا لم يقدر المراجع على كتابه قائمه من الخطوات الصغيرة، اعطى مثالا واحدا فى القائمه بحيث يستطيع المراجع ادائها و التى تجعله اقرب من اداء النشاط.

- اسئل مره اخرى "ماهى الخطوات الصغيره الاخرى التى من الممكن لك ادائها و التى تجعلك اقرب من اداء النشاط؟"
- اذا كان ممكنا قم باجراء النشاط فى الجلسه. تذكر ان تقوم بتعين درجه المشاعر قبل و بعد النشاط.
- اذا لم تكن قادرا على اجراء النشاط فى الجلسه، حاول ممارسة الخطوة الاولى فى الجلسة، اذا كان ممكنا.
- ثم اعط الواجب المنزلى: اسئل المراجع ان يقوم بالنشاط لمره او مرتين على الاقل خلال الاسبوع القادم فى الوقت او اليوم الذى تم الاتفاق عليه. كلما قام المراجع باداء النشاط اكثر، كلما اصبح احساسه احسن. و لكن يجب على المعالج الانتباه الى ان لايكون النشاط اكثر من طاقه المراجع (زياره الاقرباء كل يوم فى الاسبوع).
- "اود ان تقوم ب------فى هذا الاسبوع على الاقل لثلاثه مرات. فى كل مره تقوم بهذا النشاط، اريدك ان تنتبه الى مشاعرك و تقوم بتقديرها قبل و بعد اداء النشاط".
- تذكر خطوات الواجب المنزلى: ماذا، متى، المدة، التذكير، تقدير المشاعر قبل و بعد.
- ان الواجب البيتى للتنشيط السلوكى يجب اعطائه كل اسبوع و يجب مراجعته فى الاسبوع المقبل فى الجلسه.
- ليس من الضرورى ان تقوم باجراء بضع جلسات كامله حول التنشيط السلوكى و لكن يجب ان يستمر اعطاء الواجب البيتى حتى نهاية العلاج.

الفصل الخامس

المرحلة الخامسة (الانهاء)

- ❑ **التقييم والمتابعة.**
- ❑ **كيف ومتى يتم انهاء العملية الارشادية.**
- ❑ **المعيار النهائي لنجاح العملية الإرشادية.**

التقييم والمتابعة.

يعتبر التقييم مرحلة هامة من مراحل التخطيط والتنفيذ في مختلف المجالات، ويعتبره المرشد إحدى خطوات عملية الإرشاد. والتقييم عملية مستمرة قد تأخذ عدة صور, مثلا:

- تقييم قبلي Pre-assessment وهو يهدف إلى التعرف على المشكلة،
- تقييم العملية Process Evaluation حيث يركز على ما يجري داخل العملية الإرشادية نفسها,
- تقييم النتائج Outcome evaluation ويركز على مدى تحقيق الأهداف التي أعدها المرشد والمسترشد.
- التقويم التكويني أو المستمر Formative evaluation ويتم بالتتابع أثناء تنفيذ مراحل العملية الارشادية.
- التقييم النهائي Summative evaluation ويتم عند انتهاء من العملية الارشادية أو النشاط والوصول إلى النتائج.

إنهاء العلاقة الإرشادية:

يعتبر إنهاء العلاقة الإرشادية جانبا هاما في العملية المستمرة للإرشاد. وبجانب إنهاء الإرشاد بعد مرحلة استخدام تدخلات إرشادية لتحقيق الهدف والاطمئنان إلى الوصول إلى السلوك المستهدف, فإن هناك نقاطا أخرى يقوم فيها المرشد بإنهاء أو اختتام العلاقة الإرشادية.

- لكي يتم انهاء مناقشة لموضوع ما، أو عملية إنهاء الجلسات الإرشادية كل جلسة على حدة **فاعتماد أسلوب التلخيص (Summerizing)**
- ولكي ينهي المرشد العملية الإرشادية أو العلاقة الإرشادية, فإن عليه أن يتحقق من الاتي:
  ١) انجاز الهدف "أو الأهداف" الذي أعدها المرشد مع المسترشد, وأن السلوك المستهدف قد تحقق فعلا.
  ٢) ان عملية الإنهاء تكون عملية تدريجية وليست شيئا مفاجئا للمسترشد، ويتم التمهيد لها بالأساليب المناسبة.

نؤكد على ضرورة الانتباه الى انه عادة بعد مضيّ عدة جلسات في الإرشاد, فإن المسترشد يبدأ في إعطاء تلميحات أو إشارات بأن توقعاته من الإرشاد قد تحققت، أو لديه آمالا في الوصول إلى أهدافه بالاعتماد على جهوده, مثلا يقول: إنني أشعر فعلا بأني أفضل كثيرا الآن. كذلك فإن المرشد يراقب ظهور أدلة على أن الأهداف العامة للإرشاد قد تحققت, ويستوجب ذلك أن يكون المرشد منتبها إلى الآثار التي تلمع بسرعة. فالمسترشد غالبا يعيش خبرة من زيادة السرور بعد مضيّ جلسة أو جلستين في الإرشاد، وهو قد يشعر بأن مشكلته قد وجدت حلا لمجرد تواري الأعراض بعد جلسة من التنفيس عن المشاعر. وعندما يشعر المسترشدون بأنهم في وضع أفضل, فإنهم يعبرون عن رغبتهم في إنهاء العملية الإرشادية. فعلى المرشد في هذه الحالة ان يعرف بأن المسترشد لم يحقق استبصارا دائما, وأنه إذا أنهى إرشاده فسوف يعود مرة أخرى بمجرد أن تطرأ عليه أزمة أخرى, أو موقف آخر من مواقف اتخاذ القرارات, لذلك ينبغي التمييز بين إنهاء عملية الإرشاد من جانب المسترشد, وإنهائها عن طريق المرشد.

كما ويقابل المرشد في عمله نوعا من المسترشدين لديهم ميل للاعتماد على الآخرين ويقل تقبّلهم للمسئولية الشخصية عن أنفسهم, وهؤلاء يتوقع المرشد أن تكون لديهم مقاومة لإنهاء العلاقة الإرشادية. وفي بعض الأحيان تكون هناك رغبة من المسترشد في استمرار هذه العلاقة أيضا؛ نتيجة ما يشعر به من وحدة وحاجة إلى وجود علاقات اجتماعية تشبع من خلال العلاقة الإرشادية، وفي مثل هذه الحالات فإن الإجراء الذي يُنصَح به هو المباعدة بين الجلسات وبشكل متزايد, "مثلا بعد أسبوع ثم بعد أسبوعين ثم بعد ثلاثة أسابيع وهكذا" حتى نصل إلى الإقفال النهائي.

خطوات وطرق إنهاء العملية الإرشادية:

الخطوة الأولى (التهيئة اللفظية):

حيث يمهد للمسترشد عملية الإنهاء، وقد يكون ذلك بأن يذكره بما اتفقا عليه من وقت أو جلسات عند بداية الإرشاد "إذا كان قد حدث ذلك."يقول المرشد: ها نحن أولاء نقترب من نهاية عملنا الإرشادي، حيث أتوقع أننا في خلال أسبوعين من الآن نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذا الجهد المشترك بيننا. أو يقول على سبيل المثال في نهاية إحدى الجلسات: أتوقع أننا في خلال ثلاثة أسابيع من الآن نكون قد اطمأننا إلى تحقيق الهدف الذي حددناه معا. أو يقول: أتصور الآن أننا وصلنا إلى مرحلة يمكن أن تستمر فيها في العمل معتمدا على مهاراتك، وقد ننهي العلاقة الإرشادية بعد أسبوع من الآن.

ثم يقوم المرشد عندئذ "عند التهيئة للإنهاء" بإعداد ملخص يناقشه مع المسترشد ... وقد يكون هذا الملخص مراجعة عامة للإنجازات والترتيبات الخاصة بالإحالة أو المتابعة "التتبع"، أو يكون في صورة إعداد لخطة مستقبلية أو ملخص للحالة. ومن المهم أن يعرف المسترشد ما سيفعله في المستقبل وأن يترك الإرشاد وهو على بيّنة من أهدافه، والنتائج التي تحققت، والإجراءات المتوقعة، وحدود المقابلات "الجلسات".

الخطوة الثانية ("المتابعة"):

يجب على المرشد أن يتفادى إعطاء الفرصة لعودة العلاقة الاعتمادية من جانب المسترشد، و الانتباه الى نقطتين اساسيتين وهما:

- عدم إنهاء الحالة قبل الوصول إلى مرحلة إيجابية في الإرشاد،
- وعدم إطالة فترة الإرشاد أكثر من اللازم.

إلا أنه مع الطلاب"بالنسبة للمرشد الطلابي" في المدرسة فإن المرشد قد يرغب في تكوين نوع من الاتصال مع الطالب ليلاحظ نموه الشخصي، أو ليزوده بمزيد من المعلومات الحديثة. أو قد يرغب مثلا في تطبيق مقياس للميول المهنية؛ ليتعرف على ما حدث من تغير في ميوله.

الملحقات:

١) مخطط لمراحل الإرشاد النفسي (المشاورة)

المرحلة الاولى (بناء العلاقة)	➢ **الالتزام بقواعد العمل لمقدمي خدمات الصحة النفسية في الميدان.** ➢ **اتقان مهارات التواصل الايجابي وتجنب الاخطاء الشائعة له.** ➢ **معرفة ألاسس السليمة للمقابلة الناجحة.**
المرحلة الثانية (التقييم)	➢ **معرفة السمات الرئيسية لأهم الاضطرابات النفسية.** ➢ **التقصي عن اهم المعلومات التي ينبغي جمعها من الفرد الذي يحتمل أنه يعاني من اضطراباً نفسيّا (معرفة الاسئلة)**
المرحلة الثالثة (تحديد الأهداف)	➢ **الحالات التي ينبغي اللجوء فيها إلى اخصائيّ الصحة النفسيّة فيها.** ➢ **تحديد الاتجاهات او الاهداف للفرد و للمرشد التي ينبغي العمل عليها لمعرفة إذا كان الإرشاد يسير بشكل جيد ومتى ننهي العملية الإرشادية**
المرحلة الرابعة	➢ **طمأنة الشخص.**

(التدخلات) التي يمكن تقديمها في مراكز الرعاية الاولية	➢ **نعطي الشخص تفسيراً للوضع (التثقيف النفسي).** ➢ **نعطي النصائح للشخص عن أعراض معيّنة.** ➢ **تعليم تمارين الاسترخاء والتخيل والتنفس العميق.** ➢ **تخفيف الضغوط النفسية ومواجهتها** ➢ **تعليم مهارة ادارة المشكلات.** ➢ **العلاج السلوكي المعرفي للباحثين النفسين ان وجدوا.**
المرحلة الخامسة **(الإنهاء)**	➢ **التقييم والمتابعة.** ➢ **كيف ومتى يتم انهاء العملية الارشادية.** ➢ **المعيار النهائي لنجاح العملية الإرشادية.**

٢) أيجاز لاسس المقابلة والارشاد النفسي:

١. عرف المستفيد بنفسك وطَمأنهُ بأنك ستعمل لمساعدته.
٢. يجب اظهار الاحترام الحقيقي للمستفيد (أياً كان). ويستحسن ان يجلس المراجع بجانب المشاور بزاوية ٤٥ درجة وليس أمامه لكي لا تبدو المقابلة وكأنها تحقيق واستجواب.
٣. احرص على التواصل الودي المريح بالنظر، فالنظر في عيني المراجع منذ البداية بود يعبر عن احترامه واهتمامه به.
٤. استأذن من المستفيد للموافقة على بدء المقابلة، وأكد له أن المعلومات ستبقى سرية ولن يطلع عليها أحد.
٥. التزم الهدوء والأسترخاء وبكل مايطمئن المستفيد ولا تتحرك بسرعة ولا تتحدث بعصبية ولا تتصرف بطريقة سلطوية متعالية.
٦. لا تنشغل بأي شيئ عندما يتكلم, وقم بأجادة الأصغاء والاحساس لاي لمحات عاطفية تدل على الحالة النفسية للمراجع.
٧. وأستوضح شكوى المراجع بصورة جيدة ومستفيضه, وركز في أستكشاف جوانب وأبعاد مشكلته بإمعان وتأن وأستعمل مفردات لغوية بسيطة ومفهومة وتجنب المصطلحات العلمية المعقدة.
٨. ابتسم له حين تستقبله. وابدء كلامك بما يحب وكن واضحا ومحددا في ما تتحدث عنه وتجنب الغموض والعموميات
٩. لكي تساعد المريض على الاسترسال بالحديث, أبدء بأسئلة مفتوحة وليس بأسئلة مغلقة جوابها (نعم) أو (لا).
١٠. كن متعاطفاً مع المستفيد بمعنى تفهم وتصور كيف يشعر المرء وأظهر تشاعرك (تعاطفك) له، ولكن لا تكن عطوفاً ولا تنجرف بمشاعرك نحوه فتحزن انت ايضاً لحزنه أو تغضب لغضبه، او تكره معه.
١١. استخدم الايحاءات والإيماءات والاستجابات التي تظهر للمستفيد إهتمامك به وبأنك مصغ له وتمنحه الوقت اللازم.
١٢. وفر للمستفيد فرصة التحدث بدون وجود أحد من أهله، كما حاول أيضاً أن تتحدث مع الأقارب عند الحاجة.
١٣. فكر بأمعان بما يقوله المستفيد وأعد ذكره له بأيجاز؛ لتتأكد من صحة فهمك لما يعانيه, وانحني قليلاً باتجاه المراجع من وقت لآخر لإشعاره بالأمان والألفة والمشاركة.

١٤. تجنب الاستنتاجات السريعة والاحكام المسبقة واستخدام الكلمات أو الآراء التي تبدو وكأنها تعني أحكاما او اوامر.
١٥. تجنب النقد, المقارنة, اللوم, المقاطعة, المجادلة, وتسفيه راي الاخرين.
١٦. لا يجوز التقليل من قيمة وأهمية أي شكوى مهما كان رأينا الشخصي بها. ولايجوز أن نطلب منه كبت مشاعره (مثلاً: لاتبكِ، استرخِ قليلاً، أو إهدأ لنتفاهم), بل نبين له تفهمنا وتقديرنا لمشاعره وله الحرية في التعبير عنها. اذا لاحظت على المراجع علامات القلق والتوتر فقدم له بعض اساليب الاسترخاء (مثلا تمارين الاسترخاء، التخيل)
١٧. استكشف مصادر الدعم المتيسرة للمستفيد (مثل العائلة، الأصدقاء، العمل، الدراسة، المواهب، المساعدات القانونية، المساعدات الاجتماعية) ثم تدارس معه امكانية الاستفادة العملية منها.
١٨. اذا لاحظت على المراجع علامات الكآبة فحاول القيام بتنشيط سلوكي (مثلا: تشجيعه على الخروج لنزهة، زيارة الاقرباء، التسوق، ممارسة الرياضة، القراءة، الاستماع الى الموسيقى ...الخ)
١٩. اذا كان المراجع يعاني من اثار صدمة نفسية فلا تنسى ان تساعده وتشجعه على الحديث عن ذكريات الحادث المؤلم ولكن بدون الضغط عليه بالحديث.
٢٠. اذا وجدت لدى المراجع افكارا انتحارية او انه حاول الانتحار فعلا فيجب عليك تبليغ اهله فورا واحالته الى طبيب نفسي.
٢١. وثق الاشياء المهمة من كلام المريض للاحتفاظ بها والتي قد تساعدك في معرفة مشكلة المريض والتي يمكنك الرجوع اليها لاحقا.
٢٢. حين تقدم خدمة المشاورة والأرشاد النفسي فتذكر:
- ان تجزئة المشكلة لعدة مشاكل أصغر يساعد في تيسير حلها، ويفضل البدء بحل المشكلة الأهم بالنسبة للمستفيد.
- ساعده على اكتشاف مصادر الدعم المتيسرة والبحث عن الحلول والبدائل الممكنة وبالاستفادة من الموارد المتيسرة.
- انك لا تقرر الحل لمشكلة المراجع وانما تساعده لإعادة ترتيب أفكاره بشكل منتظم ليختار بنفسه الحل الأنسب له.

٢٣. يجب التاكد من وصول المراجع الى اعلى حالة من الاقتناع بأن العامل الصحي قد فعل كل ما بوسعه لمساعدته في إنهاء معاناته قبل مغادرته لكي يتواصل معك.
٢٤. حدد موعد جلسة المشاورة القادمة, وضرورة اختيار الوقت والمكان المناسب له لاجراء الاتصال وحوارات لاحقة.

٣) حالات يمكن الاستفادة منها في مناقشة حالات الاضطرابات النفسية ولعب الادوار :

الحالة: ١

رجل في الرابعة والأربعين من العمر يرتاد المركز الصحي منذ عدّة أشهر بسبب مشكلات جسدية عديدة. ومن مشكلاته الرئيسيّة أنّه لا ينام جيّداً، وأنّه غالباً ما يشعر بالغثيان في الصباح، ويشعر بتوعّك بشكل عامّ.
قدم إلى المركز الصحي شاكياً من حرقة شديدة في المعدة. لم تنفعه مضادات الحموضة، كما من قبل. عاينه أحد الأطبّاء، فوصف له مزيداً من مضادّات الحموضة والرانيتيدين، وهو دواء يساعد في التئام قروح المعدة. وعندما أوشك على المغادرة لاحظ الطبيب أنّ المريض شديد التعرّق وأنّ يديه ترتجفان. فسأله ما إذا كان يعاني مشكلات أخرى. فأخذ يبكي واعترف أنّ مشكلته الرئيسيّة إقدامه على شرب كميّات متزايدة من الكحول في الأشهر القليلة الماضية للتعامل مع الضغوط النفسية الذي يتعرّض له في العمل وأنّه لا يستطيع أن يفوّت يوماً واحداً من دون أن يشرب. (فماهي الحالة)

الحالة: ٢

طالب ثانويّ في الثامنة عشرة من العمر. ولطالما كان مجدّاً ومثابرا . غير أنّ والدته لاحظت مؤخّراً أنّه يعود إلى البيت في ساعة متأخرة من الليل، وأنّ علاماته في المدرسة أخذت تتراجع، وأنّه ينفق مزيداً من المال, ولاحظت أنّ بعض النقود فُقدت من محفظتها. كما لاحظت أنّه لم يعد يقضي وقته مع أصدقائه القدامى والأسرة، وأنّه يخرج مع مجموعة جديدة من الأصدقاء الذين لم يقدّمهم إلى والديه.

اقترحت عليه أمّه استشارة مرشد صحي لكنّه رفض في البداية وبعدد الحاح امه ذهب معها الى المرشد النفسي: وكان الشاب متردّداً في البداية. لكنّه بعد أن ازدادت ثقته في المرشد، اعترف بأنّه يتعاطى الهيروين بانتظام منذ عدّة أشهر، وأنّه أصبح مدمناً. وقد حاول التوقف عدّة مرّات، لكنه كان يشعر بمرض شديد فيعاود تعاطيه. وقال إنّه يريد المساعدة لكنّه لا يعرف إلى من يلجأ. (فماهي الحالة)

الحالة: ٣

طالباً جامعياً في الخامسة والعشرين من عمره. أُحضِرَ إلى المركز الصحي العام الماضي بعد أن بدأ يقفل على نفسه باب غرفته. كان الطالباً جيّداً ولكنّه رسب في امتحاناته الأخيرة. قالت أمّه إنّه يقضي ساعاتٍ ينظر إلى الفضاء، ويتمتم أحياناً وكأنّه يُكلّم شخصاً وهميّاً. نقله أهله إلى العيادة. وقد رفض التحدّث إلى المعالج في البداية، ولكن بعد قليل أقرّ بأنّه يعتقد أنّ أهله وجيرانه يتآمرون لقتله، وبأنّ الشيطان يتدخّل في تفكيره. قال إنّه يسمع جيرانه يتكلّمون عنه ويقولون كلاماً شرّيراً وراء بابه، وإنه يشعر بأنّه ممسوس، ولكنّه لم يفهم لماذا جيء به إلى العيادة مع أنّه ليس مريضاً. (فماهي الحالة)

الحالة: ٤

سيّدة في الحادية والثلاثين، أحضرها زوجها إلى المركز الصحي لأنها بدأت قبل أسبوع تتصرّف بشكل غير اعتياديّ. كانت تنام أقلّ من العادة وتتحرّك باستمرار. أضف إلى ذلك أنّها لم تعد تهتمّ بالمنزل والأولاد كما في السابق. كانت تتكلّم كثيراً وغالباً ما تتفوّه بأمور غير حقيقيّة وتفوق الطبيعة. فقد قالت مثلاً إنّ باستطاعتها شفاء الآخرين، وإنّها تنتمي إلى عائلة ثريّة (مع أنّ زوجها موظف بسيط)، كما أنّها باتت تُنفق أكثر من عادتها على الملابس ومساحيق التجميل. وعندما حاول زوجها إحضارها إلى العيادة، ثار غضبها وحاولت ضربه، ولكنْ جيرانه ساعدوه على نقلها بالإكراه. (فماهي الحالة)

الحالة: ٥:

رجلٌ في الرابعة والثلاثين، بدأت تصدر عنه تصرّفات غريبة فجأةً، قبل إحضاره إلى المركز الصحي بثلاثة أيّام. فقد أصبح كثير الحركة، يقول كلاماً تافهاً ويتصرّف بطريقة وقحة، فينزع ثيابه أمام الناس. لم يسجَّل له أيّ مرض نفسيّ سابق، ولم يدوَّن في سجلّه الطبيّ سوى ارتفاع في الحرارة وآلام في الرأس، قبل ظهور سلوكه الغريب بأيّام قليلة.

عند إحضاره إلى المركز الصحي، بدا مشوّشاً، ولم يُدرك لا المكان ولا الزمان. كان يرى أشياء لا يراها سواه، ولم يقدر أن يجيب بدقّة عن أسئلة المرشد النفسي. كانت حرارته مرتفعة أيضاً، وتبين بعد اجراء الفحص الجسدي عليه بأنّه يعاني من الملاريا الدماغيّة. لذلك نؤكد بعدم اهمال الجانب الجسدي في التقييم كما في الجانب النفسي والعكس صحيح.

الحالة: ٦

امراة تتحدث عن نفسها وتقول كان الأمر مخيفاً جدّاً. كنت جالسةً في الباص، وفجأةً بدأ قلبي ينبض بسرعة فأحسست بأنني سأصاب بنوبة قلبيّة. شعرت بصعوبة في التنفّس، ثمّ انتابني شعورٌ بأنّ النّمل يسرج على يديّ ورجليّ. تسارعت دقات قلبي أكثر فأكثر، وأحسست بحرارة في جسمي الذي راح يرتجف. أردت أن أخرج من الباص في الحال، ولكنّه كان يسير بسرعة فشعرت بالاختناق. أكثر ما أخافني هو أنّني قد أنهار أو أصاب بالجنون وعندما توقّف الباص في إحدى المحطات خرجتُ منه مسرعةً، بالرغم من أنّني كنت لا أزال بعيدةً عن المنزل. ومع ذاك، لم أستطع أن أستقلّ الباص... ومجرّد التفكير في ركوب الباص يشعرني بالغثيان.

وفي خلال السنتين الأخيرتين لم أعد أخرج من البيت إطلاقاً بسبب هذا الخوف، والآن ليس لي سوى عدد قليل من الأصدقاء وحياتي الاجتماعيّة شبه معدومة, لا أعرف ماذا أفعل وكنت خائفةً جداً من استشارة طبيب نفسيّ. ففي النهاية أنا لست مريضةً نفسيا. (فماهي الحالة)

الحالة: ٧

كنت في السابعة عشرة من عمري عندما بدأت أسمع اصواتا. في البداية لم أعرف إنْ كانت موجودةً في رأسي أم في الحقيقة. ولكن فيما بعد، صرت أسمع أشخاصاً غرباء يتكلّمون عنّي ويقولون كلاماً شرّيراً.

سمعت صوتاً في إحدى المرّات يقول لي أن أقفز إلى إحدى البنايات، وصرت أقف قرب تلك البناية أيّاماً، وأشعر بأنّ عليّ أن أطيع ذلك الصوت. شعرت بأنّ التلفزيون يتحكّم بأفكاري، وأحياناً كنت على ثقة بأنّ سمّاً قد دُسَّ في طعامي وأنّ عصابةً ما تريد قتلي. كنت أغضب كثيراً، وعندما فقدت أعصابي تماماً وأقدمت على ضرب أحد الجيران، اصطحبني أهلي إلى المستشفى. (فماهي الحالة)

الحالة: ٨

امراة في اواخر الثلاثينيات من العمر تتحدث عن ماتعانيه: بدأت المشكلة تدريجيّا، ولكن قبل أن أعرف فقدت كل الرغبة في الحياة. فحتّى أولادي وعائلتي لم ينجحوا في «إدخال السعادة إلى قلبي. كنت أشعر بالتعب طوال الوقت، ولا أستطيع النوم...أستيقظ عند الساعة الثانية أو الثالثة صباحاً وأمضي الفترة المتبقية من الليل أتقلّب في الفراش. فقدت الشهيّة، مع أنّني كنت من محبّي الأكل، وخسرت الوزن. حتّى إنّني لم أعد أهتمّ للقراءة لأنّي فقدت القدرة على التركيز. كان رأسي يؤلمني. وأصبحت عبئاً على الأسرة، وما إلى ذلك. أمّا أسوأ ما في الأمر فهو أنّ وضعي هذا كان يحرجني فلم أستطع أن أخبر أحداً. بدأت حماتي تشتكي من خمولي. وفي إحدى المرّات شعرت برغبةٍ في إنهاء حياتي وعندئذٍ خفت كثيراً فأخبرت زوجي... وذلك بعد مضيّ شهرين على شعوري بالمرض. (فماهي الحالة)

الحالة: ٩

كنت أشعر بأنّي مفعمٌ بالنشاط فلست بحاجةٍ إلى النوم. وفي الواقع، لم أنم إلا قليلا جدّاً في تلك الأيّام. صرت منهمكاً في عدّة مشاريع ومخططات إلا أنّني لم أنجح في إتمام أيّ منها. أصبحت سريع الانفعال عندما يحاول أحدٌ ردعي. وفي أحد الأيّام تشاجرت مع واحد من شركائي في العمل حول أحد مشاريعي، ولم أدركْ خطأي عندما كنت في أوج الغضب. شعرت أحياناً بأنّ لي قوىً مميّزة وبأنّني أستطيع أن أشفي الآخرين. والأسوأ أنّني رحت أبذر المال حتّى كدت أجرّ الأسرة إلى الإفلاس. (فماهي الحالة)

الحالة: ١٠

رجل مسن يقول لا أعرف ما يجري. يبدو أنّني أنسى أموراً بسرعة. في أحد الأيّام جاءت زوجتي لتقدّم لي الشاي، وللحظةٍ لم أعرف من هي. وفي مرّةٍ أخرى، كنت سائراً باتجاه المنزل، وفجأة لاحظت أنّني لا أعرف أين أنا، مع أنّني في منطقتي. ظننت أنّني شارد الذهن بسبب تقدّمي في السنّ، إلا أنّ الأمور ازدادت سوءاً... ثمّ تذكّرت والدي الذي توفّي بعد أن فقد ذاكرته ببضع سنوات، وأنا الآن خائف من أن تصيبني المشكلة نفسها. (فماهي الحالة)

الحالة :١١

بدات مشكلاتي في العمل حين ازداد طلبي للإجازات المرضيّة بشكل كبير. كنت أشعر دائماً بآلام في المعدة، ومؤخّراً أصبت باليرقان. عندئذٍ بدأ القلق يساورني حيال معاقرة الكحول. وما يخيفني كثيراً هو أنّني أشعر بانزعاج كبير عندما أستيقظ في الصباح. فكأنّ عليّ أن اتناول كأساً لكي أبدأ نهاري. وفي هذه الفترة، بدأت أشرب حتّى قبل الغداء. لا أعرف تماماً كميّة الكحول التي أشربها، ولكنّني لم أكتفِ يوماً. (فماهي الحالة)

الحالة: ١٢

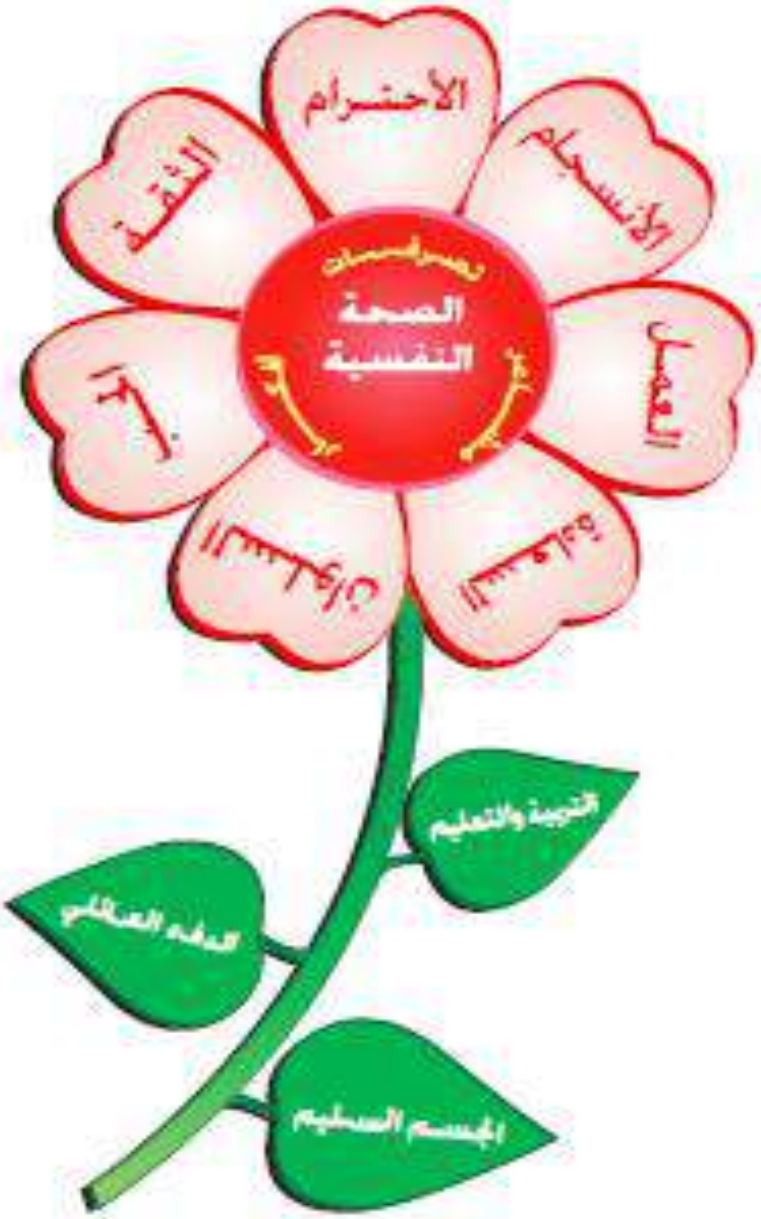
امراة في الثالثة والعشرين رُزقت بطفلها الأول. في الأيام الأولى للولادة، أخذت تشعر بميل إلى البكاء واختلطت عليها الأمور. طمأنتها القابلة بأنّها تمرّ في طور وجيز من الكرب العاطفيّ، كالذي تشهده العديد من الأمهات. واقترحت عليها وزوجها قضاء الكثير من الوقت معاً والاعتناء بالطفل وإنّ مزاجها سيتحسّن. وكما هو متوقّع، شعرت المراة بتحسّن بعد عدّة أيام. وبدأ كل شيء على ما يرام. وبعد اسبوعين بدأت المراة تشعر بالتعب والضعف بشكل تدريجيّ، واضطراب في النوم وكانت تصحو في الصباح الباكر على الرغم من الشعور بالتعب وأصبح رأسها مليئاً بالأفكار السلبيّة عن نفسها وعن طفلها ما أثار عندها الخوف وأصبح زوجها يشعر بالغضب من كسل سلوكها ولا مبالاتها. (فماهي الحالة)

الحالة: ١٣

امرأة في الثامنة والخمسين، توفّي زوجها فجأة قبل عام. واصبحت تسكن المنزل وحيدة فأولادها متزوجون وهم مع اسرهم, وسرعان ما بدأت تشهد حالات أرق وفقدان شهيّة بعد وفاته. وأخذت تشعر بصداع وآلام في الظهر وآلام في المعدة وغير ذلك من الاضطرابات الجسدية، ما دفعها إلى زيارة المركز الصحي فقيل لها إنّها بخير ووصفوا لها حبوباً منوّمة وفيتامينات. شعرت بتحسّن على الفور، لا سيّما في النوم. غير أنّ نومها ساء ثانية في غضون أسبوعين فراجعت مرة اخرى وصفوا لها المزيد من الحبوب المنوّمة والحقن واستمرّ ذلك لعدة شهور، إلى أن أصبحت عاجزة عن النوم من دون حبوب منوّمة. (فماهي الحالة)

الحالة: ١٤

شاب في الثلاثين من عمره تعرّض لحادث سير خطير. كان راكباً درّاجته الناريّة و صديقه على المقعد الخلفيّ. فصدمت حافلة الدرّاجة من الخلف، فسقط الشاب وصديقه عنها وارتعب عندما رأى صديقه يقتل تحت عجلات الحافلة. بعد بضعة أيام من الحزن الشديد والصدمة، وبعد شهر من الحادث بدأ الشاب يعاني نوبات من الخوف وضيق في التنفس وشعور بأنّ قلبه يخفق بشدّة. وكان والده يشكو من مشكلات في القلب، فأصبح الشاب قلقاً من أن يصاب بمشكلة في القلب أيضاً. أشار عليه الطبيب بإجراء اختبارات فتبين أنّ قلبه سليم. وبدأت تراود الشاب كوابيس في أثناء النوم، بحيث يتكرّر أمامه مشهد الحادثة التي تعرّض لها وكانت صور الحادثة تراوده حتى عندما يكون مستيقظاً، فيشعر بالخوف والتوتّر. وبدأ يعاني اضطراباً في النوم. وأخذ يشعر برغبة في الانتحار. (فماهي الحالة)


الاحترام
الانسجام
الثقة
الصحة النفسية
العمل
التربية والتعليم
الدفاع المدني
الجسم السليم